1. Fundamentos teórico-metodológicos para el análisis del proceso salud-enfermedad en las sociedades capitalistas

"*La producción de plusvalía o extracción de trabajo excedente* —dice Marx— constituye el contenido específico y el fin concreto de la *producción capitalista*, cualesquiera que sean las transformaciones del *régimen mismo de producción* que puedan brotar de la supeditación del trabajo al capital" (Marx 1973, I:237). Para que se presente lo anterior, es necesario que se den determinadas condiciones sociales: la existencia de una clase social que posea sólo su fuerza de trabajo para subsistir, y de otra que monopolice los medios de subsistencia y de producción.*

Esta situación históricamente determinada por un largo proceso en que una parte reducida de la población llega a controlar los medios para producir los bienes que la sociedad requiere, conduce a la explotación de la clase proletaria por la capitalista, aun cuando en forma individual los miembros de ésta puedan no proponérselo. Ello se debe a que las leyes objetivas del modo de producción capitalista muestran que el desarrollo y consolidación de éste como sistema social sólo se logra

*"El proletariado —dice Engels— no tiene apoyo; no puede vivir por sí mismo ni un solo día. La burguesía se apropia el monopolio de todos los medios de subsistencia. . . el proletariado sólo puede recibir de esta burguesía lo que necesita, mientras ella es protegida en su monopolio por la fuerza del estado. El proletariado es, por lo tanto, legalmente y de hecho, el esclavo de la burguesía; ella puede disponer de su vida y de su muerte. Le ofrece los medios de subsistencia, pero por un equivalente, por su trabajo" (1977:109).

—históricamente— al incrementarse la acumulación del capital a través de la producción de plusvalía. La única clase cuyo trabajo puede producirla es el proletariado, por lo que el capitalista recurre a diferentes mecanismos para "hacer que rinda la mayor plusvalía posible y que, por tanto. . . pueda explotar con la mayor intensidad la fuerza de trabajo" (Marx 1973, I:267).

La situación anterior genera una lucha entre ambas clases: una que busca extraer la máxima plusvalía al menor costo (la burguesía o capitalista), y la otra que trata de evitarlo por diferentes medios (proletariado), ya que "al crecer la masa de obreros empleados simultáneamente crece su fuerza de resistencia, aumentando también, como es lógico, la presión del capital por vencerla" (*ibid.*:267).

La sociedad se organiza, por lo tanto, para producir y reproducirse de acuerdo con relaciones capitalistas de producción que permiten y alientan la obtención de la máxima plusvalía posible. Esto conlleva necesariamente a la producción generalizada de mercancías a tal grado que todo lo que cae en la órbita de tales relaciones se convierte en mercancía.

La fuerza de trabajo no escapa a esta realidad: se la considera una mercancía más que compra el poseedor del capital en tanto puede consumirla en el proceso de trabajo junto con otras mercancías (materias primas, materias auxiliares, instrumentos de trabajo). "*El proceso de trabajo* no es más que el *consumo* de la mercancía fuerza de trabajo comprada por el capitalista. . . (*ibid.*:137) y "*el proceso de consumo de la fuerza de trabajo* es, al mismo tiempo, *proceso de producción de la mercancía y de la plusvalía*" (*ibid.*:128).

Empero, la mercancía fuerza de trabajo tiene una peculiaridad que la distingue del resto de las mercancías: producir más valor del que posee, y del cual se apropia el capitalista. Esto último se explica porque el capitalista compra la fuerza de trabajo como un objeto que se consume en un proceso en el que intervienen otros elementos comprados también por él. Esto le da derecho —legalmente, desde el punto de vista del derecho burgués— a obtener el mayor beneficio, en tanto que el propietario de la fuerza de trabajo sólo recibe el valor —expresado en dinero— que necesita para conservarla y reproducirla (alimentación, vivienda, etcétera). Tal valor se encuentra determinado por las condiciones sociales que se consideran suficientes para su incorporación diaria, durante toda su vida productiva, al proceso de trabajo.

Por lo tanto, "el capital —señala Marx— no pregunta por el *límite de vida de la fuerza de trabajo*. Lo que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de trabajo que puede movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. Y, para conseguir este rendimiento máximo, no tiene inconveniente en *abreviar la vida de la fuerza de trabajo*" (*ibid.*:208).

El consumo de la fuerza de trabajo en el proceso productivo implica un desgaste de energías, de cerebro, de nervios, que repercute directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, en la salud del obrero: mayores enfermedades y accidentes de trabajo más frecuentes, envejecimiento prematuro y reducción de la esperanza de vida.

Marx relacionó lo anterior con las características inherentes al modo de producción capitalista: "La producción capitalista, que es, en sustancia, producción de plusvalía, absorción de trabajo excedente, no conduce solamente al *empobrecimiento* de la fuerza humana de trabajo, despojada de sus condiciones normales de desarrollo y de ejercicio físico y moral. *Produce, además, la extenuación y la muerte prematuras de la misma fuerza de trabajo*. Alarga el *tiempo de producción* del obrero durante cierto plazo a costa de acortar la *duración de su vida*" (1973, I:208).

Importa subrayar que esta realidad está determinada en gran medida por la división del trabajo que se acelera con el surgimiento del modo de producción capitalista, como una forma de incrementar la fuerza productiva del trabajo social para obtener más plusvalía. Esto repercute en el desarrollo del ser humano en tanto que todas sus energías se ponen al servicio del capital para producir plusvalía. Los planteamientos de Marx sobre las repercusiones de la división del trabajo en la salud del proletariado son concretos: "toda división del trabajo en el seno de la sociedad lleva aparejada inseparablemente cierta degeneración física y espiritual del hombre. Pero el período manufacturero acentúa este desdoblamiento social de las ramas de trabajo de tal modo y muerde hasta el punto, con su régimen peculiar de división, en las raíces vitales del individuo, que crea la base y da el impulso para que se forme una *patología industrial*" (1973, I:296).

Al capitalista —como clase social— le tiene sin cuidado el empobrecimiento físico y espiritual de sus obreros, ya que lo que más le interesa es arrancar el máximo trabajo excedente con el menor costo posible a fin de incrementar la acumulación de capital; de lo contrario perecería —como clase, insistimos— y

esto es algo que bajo ningún concepto pasa por su mente. Ello supone explotar al trabajador sin importar las consecuencias que tiene para la salud de éste. Marx es claro cuando señala que al capital le importa poco la salud y la duración de la vida del obrero, *a menos que la sociedad le obligue a tomarlas en consideración* (*ibid.*:212) presionada por las luchas del proletariado.

Por lo tanto, cuando la fuerza de trabajo se enfrenta a condiciones laborales que amenazan su conservación y reproducción (principalmente durante la consolidación del capitalismo) el estado comienza a instaurar regímenes de seguridad social a fin de mantener la fuerza de trabajo en condiciones de ser explotada por el capital.*

Históricamente, el desgaste de la fuerza de trabajo se acentúa cuando el modo de producción capitalista tiene necesidad de extraer más plusvalía. Para ello prolonga la jornada de trabajo (plusvalía absoluta), o intensifica el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo mediante la incorporación de los avances tecnológicos al proceso productivo (plusvalía relativa), lo que, a su vez, provoca una intensificación del trabajo al realizar el obrero un mayor esfuerzo durante el mismo lapso de tiempo. Se supeditan los movimientos del obrero a los de la máquina y se reducen los "tiempos muertos" o poros.

Poco a poco esta última forma de extracción de plusvalía gana terreno en los países donde surge primero el modo de producción capitalista. Ello se debe, por un lado, al límite que impone la resistencia fisiológica del individuo y, por otro, al desarrollo del movimiento obrero que obliga a la sociedad y al estado a detener la prolongación de la jornada de trabajo y, después, a reducirla. Menos tiempo de trabajo y más daños a la salud se derivan de esta situación: "la reducción de la jornada —señaló a su tiempo Marx— ha provocado ya una intensidad de trabajo tal, que amenaza con destruir la salud de los obreros y, por consiguiente, *la propia fuerza de trabajo*. . ." (1973, I:344) en la medida en que "la intensidad creciente del trabajo supone un despliegue mayor de trabajo dentro del mismo espacio de tiempo" (*ibid.*:438).

En las formaciones sociales capitalistas el obrero enfrenta, además, otra realidad que le ha sido impuesta: carece por lo general del tiempo necesario para formarse una cultura, para desarrollarse intelectual y espiritualmente, ya que el trabajo

*Véase mi libro *Capitalismo y enfermedad*, capítulo 4.

—como categoría social— se encuentra presente en todas las esferas y momentos de su vida, determinando sus actividades fuera de la fábrica. Por lo tanto, aun cuando la actividad laboral concreta termina en el momento en que el obrero deja el lugar de trabajo, su huella trasciende a las relaciones familiares y a otros campos como la política, el arte, la ciencia, la recreación y la salud.

Esta realidad se debe a que al capital le interesa, por encima de la satisfacción de las necesidades y aspiraciones señaladas en el párrafo anterior, proporcionar al obrero los medios indispensables (alimentación, vivienda, vestido) para conservar la fuerza de trabajo en condiciones físicas para seguir explotándola. Se opera aquí un ahorro para el capitalista que, por otra parte, es una ley: "obtener mucho trabajo por la menor cantidad posible de dinero (1973, I:453), sin importar los daños a la salud del trabajador (nos referimos, obviamente, al capitalista como clase, y no como individuo aislado a quien quizás llegue a interesarle la salud de sus asalariados).

De ahí que el capital trate al obrero como a un objeto de su propiedad —aunque sea por algunos días, semanas o meses—, por lo que no se anda con miramientos para explotar la fuerza de trabajo en tanto que es fuente de plusvalía. Al respecto, Marx es muy claro al señalar que el capital "usurpa al obrero el tiempo de que necesita su cuerpo para crecer, desarrollarse y conservarse sano. Le roba el tiempo indispensable para asimilarse el aire libre y la luz del sol. Le capa el tiempo destinado a las comidas y lo incorpora siempre que puede al proceso de producción haciendo que al obrero se le suministren los alimentos como a un medio de producción más, como a la caldera carbón y a la máquina grasa o aceite. Reduce el sueño sano y normal que concentra, renueva y refresca las energías, al número de horas de inercia estrictamente indispensables para reanimar un poco un organismo totalmente agotado" (Marx 1973, I:208) *

La ley del mayor beneficio con el menor costo posible se

*En términos similares se expresa Engels (1977:153) cuando señala que "el trabajo [capitalista] no deja al obrero ningún campo para la actividad intelectual, le es necesaria la mayor atención, puesto que para atender bien su trabajo no debe pensar en otra cosa. Un trabajo así es una condena; quita al obrero todo el tiempo disponible, quedándole sólo el necesario para comer y dormir, nada para el ejercicio del cuerpo al aire libre, para gozar de la naturaleza, y no hablemos de la actividad intelectual; ¡no debe degradarse a los hombres, con semejante condena, a la condición de bestias!"

presenta, además, en el proceso productivo, ya que "el obrero trabaja *bajo el control del capitalista*, a quien su trabajo pertenece. El capitalista se cuida de vigilar que este trabajo se ejecute como es debido y que los medios de producción se empleen convenientemente, es decir, sin desperdicios de materias primas y cuidando de que los instrumentos de trabajo se traten bien, sin desgastarse más que en aquella parte en que lo exija su empleo racional. . ." (*ibid.*:137).

Empero, Marx no se queda con este planteamiento economicista; va más allá al destacar las consecuencias de la organización capitalista del proceso de trabajo en la salud del proletariado: "la tendencia a *economizar los medios sociales de producción*. . . se convierte, en manos del capital, en un *saqueo sistemático contra las condiciones de vida del obrero durante el trabajo*, en un robo organizado de espacio, de luz, de aire y de los medios personales de protección contra los procesos de producción malsanos o insalubres, y no hablemos de los aparatos e instalaciones para comodidad del obrero" (*ibid.*:352-353). E insiste en su planteamiento materialista para analizar la salud-enfermedad de la clase obrera, es decir, en la necesidad de considerar la base económica de la sociedad (el modo de producción capitalista que se basa en la explotación del trabajador) para explicar los daños a la salud: "el régimen de producción capitalista —dice Marx— como corresponde a su carácter contradictorio y antagónico, da un paso más y *dilapida la vida y la salud del obrero*, considerando la degradación de sus mismas condiciones de vida como economía en el empleo del capital constante y, por tanto, como medio para la elevación de la cuota de ganancia" (*ibid.*, III:99; cursivas nuestras).

De lo expuesto hasta aquí podemos señalar que la explotación del obrero se sitúa en dos momentos e instancias íntimamente relacionados:

1] el capitalista paga sólo una parte del valor que produce la fuerza de trabajo, lo necesario para que el obrero y su familia puedan subsistir en las condiciones que exige la explotación capitalista; el resto se lo apropia el capitalista (plusvalía);

2] las leyes objetivas del modo de producción capitalista obligan a mantener al obrero en condiciones de trabajo que directa o indirectamente dañan su salud (accidentes y enfermedades laborales y reducción de su vida). Esto se debe a que al capital le interesa obtener la máxima plusvalía, reduciendo hasta donde sea posible los costos de producción, y para ello no tiene

inconveniente —como dice Marx— "en abreviar la vida de la fuerza de trabajo", que, como ya vimos, el capitalista compra como una mercancía más que incorpora al proceso productivo.

Estos dos hechos, indisolublemente vinculados, conforman las causas de la patología industrial de la clase obrera, la cual trasciende a otras esferas de la vida y repercute en el ámbito familiar y social del obrero, ya que éste continúa siéndolo aún después de salir de la fábrica. De ahí, pues, que toda la problemática que aquí se genera afecta su vida y la de las personas que viven con él, ya que "las condiciones del proceso de producción son en gran parte condiciones de su proceso de vida activa, sus condiciones propias de vida" (Marx 1973, III:99). Por ello, insiste Marx, "para comprender en todo su alcance las leyes de la acumulación, no puede perderse tampoco de vista la situación del obrero *fuera* de la fábrica, su comida y su vivienda (*ibid.*, I:554).

De lo antes expuesto se deduce que "a medida que se acumula el capital, tiene necesariamente que empeorar la situación del obrero, *cualquiera que sea su retribución*, ya sea ésta alta o baja... Esta ley —continúa diciendo Marx— determina una *acumulación de miseria* equivalente a la *acumulación de capital*. Por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza es, en el polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio producto como capital, acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de despotismo y de ignorancia y degradación moral" (*ibid.*:547).

De lo señalado hasta aquí se desprende que las condiciones materiales de existencia difieren en ambas clases sociales (burguesía y proletariado) ya que aquélla se apropia el producto del trabajo social en tanto que ésta vive de su salario, que representa sólo una parte del valor que produce. Esta realidad objetiva origina una situación diferente entre las dos clases con respecto a la enfermedad (tipo de patologías, frecuencia y gravedad), la manera en que se adquiere y la esperanza de vida, situación que analizan Marx y Engels, como veremos después.

Volviendo al análisis de las condiciones del proceso de producción en la industria moderna, debe destacarse que éstas convierten al obrero en parte de la maquinaria y del medio laboral, pero como algo pasivo, ya que sólo debe estar atento a los movimientos de la máquina. Éstos condicionan los ritmos y movimientos del obrero y las necesidades que aquélla tiene (aceite, limpieza, reparaciones), deben ser satisfechas por el trabajador de manera escrupulosa, de lo contrario la valorización

del capital se pondría en peligro. Por lo tanto, "lejos de ser el obrero quien maneja las condiciones de trabajo, son éstas las que le manejan a él" (Marx 1973, I:350).

Lo anterior origina, sin duda, que el trabajo sea monótono, rutinario, repetitivo, y poco a poco anule la capacidad creativa del individuo. El obrero no se identifica con un proceso de trabajo cuyas condiciones le han sido impuestas, ni con el producto final, ya que no participa en la determinación de para qué, cuánto, cuándo, cómo y dónde producirlo.

La situación que vive el obrero de la moderna industria trae serias repercusiones para su salud, sobre todo enfermedades psicosomáticas y psíquicas. Marx y Engels destacaron las repercusiones del trabajo maquinizado en la salud del obrero: "el trabajo mecánico afecta enormemente al sistema nervioso, ahoga el juego variado de los músculos y confisca toda la libre actividad física y espiritual del obrero", señala Engels (citado por Marx 1973, I:349-350). Por lo tanto, "hasta las medidas que tienden a facilitar el trabajo se convierten en medio de tortura, pues la máquina no libra al obrero del trabajo, sino que priva a éste de su contenido" (Marx 1973, I:350).*

El desarrollo del capitalismo no sólo no reduce la explotación del obrero sino que conlleva, como una ley histórica natural, al incremento del ejército industrial de reserva, cuya absorción por el aparato productivo se vuelve cada vez más difícil. Esto se debe a la presencia cada vez más acentuada de la división del trabajo y del perfeccionamiento de las máquinas que permiten elevar la capacidad productiva del trabajo.

Empero, la acumulación capitalista requiere de ese ejército de reserva: "la existencia de un sector de la clase obrera condenado a ociosidad forzosa por el exceso de trabajo impuesto a la otra parte, se convierte en fuente de riqueza del capitalista individual y *acelera al mismo tiempo la formación del ejército industrial de reserva, en una escala proporcionada a los progresos de la acumulación social*" (*ibid.*:538-539).

*La manufactura —dice Marx— "convierte al obrero en un monstruo, fomentando artificialmente una de sus habilidades parciales, a costa de aplastar todo un mundo de fecundos estímulos y capacidades" (Marx 1973, I:293); "lo que los obreros parciales pierden, se *concentra*, enfrentándose con ellos, en el capital. Es el resultado de la división manufacturera del trabajo el erigir frente a ellos, como *propiedad ajena y poder dominador, las potencias espirituales* del proceso material de producción" (*ibid.*:294).

Opera pues, una ley: "*Cuanto mayores son la riqueza social*, el capital en funciones, el volumen y la intensidad de su crecimiento y *mayores también, por tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo*, tanto mayor es el ejército industrial de reserva" (*ibid.*:546).

Esta superpoblación relativa (ejército industrial de reserva) sufre en mayor medida los problemas de salud que padece el proletariado activo, debido a que carece de una base económica estable que le permita obtener los satisfactores necesarios (alimentación, vivienda) para no sucumbir ante la patología de la pobreza.

Con respecto al ejército obrero en activo, los elementos teóricos y los datos empíricos disponibles muestran que la forma en que se consume la fuerza de trabajo en el proceso de producción y la manera en que se conserva y reproduce (proceso desgaste-reproducción) difieren dentro del proletariado. Ello se debe a que éste no es un todo monolítico, es decir, un conjunto de personas que poseen los mismos elementos objetivos y subjetivos.

En el interior del proletariado existen fracciones o sectores que se diferencian por el hecho de trabajar en ramas distintas de la economía, en las que existen grados diversos de desarrollo de las fuerzas productivas y de concentración y composición orgánica del capital. También se diferencian por el tipo de ocupación que tienen, por las condiciones de empleo y de trabajo (forma concreta de insertarse al proceso productivo), lo cual va a determinar el monto del salario y la manera en que se reproduce la fuerza de trabajo (vivienda, alimentación, vestido).

Asimismo, el nivel de conciencia política y el nivel educativo varían de uno a otro sector del proletariado, así como la legislación específica (contratos colectivos) que regula la relación capital-trabajo. Todo ello sucede no obstante que los miembros del proletariado poseen una realidad común e histórica que los identifica como una clase objetiva, una clase en sí: carecen de medios de producción y para subsistir disponen sólo de su fuerza de trabajo, que venden al capitalista como una mercancía.

De lo anterior se desprende que *existe una relación entre la forma en que grupos específicos de trabajadores producen y se reproducen y la forma en que se enferman, la patología que padecen y de qué mueren, así como su esperanza de vida y las características de los servicios médicos a los que acuden.*

2. Algunas tesis de la sociología médica marxista

I

Un planteamiento expuesto hace más de un siglo por los fundadores del marxismo ha vuelto a cobrar plena vigencia en los últimos años, precisamente cuando las contradicciones del sistema capitalista lo han llevado a una profunda crisis que amenaza su propia existencia.

Las consecuencias del desarrollo capitalista se manifiestan en forma concreta en la salud de los grupos sociales que componen a las distintas sociedades históricamente determinadas: surgen nuevas enfermedades o se acentúa la presencia de otras, y se intensifican los accidentes. El surgimiento y las características de la enfermedad se presentan, por lo tanto, como resultado de la forma en que la sociedad produce y se reproduce, que responde a las características que el capitalismo impone en la dialéctica de su desarrollo.

Las clases trabajadoras se encuentran sometidas a una mayor explotación por parte del capital o engrosan las filas del ejército industrial de reserva, lo que, conjuntamente con el subempleo y la inflación, repercute directamente en sus condiciones de trabajo y de vida en general. Se observa en toda su dimensión el problema del hacinamiento en las viviendas y en los locales de trabajo, así como una mayor desnutrición y menores oportunidades de educación y esparcimiento. Todo ello crea un campo propicio para que se desarrolle una patología propia del capitalismo.

Lo anterior demuestra el carácter social del proceso salud-enfermedad en un nivel general, en tanto que se encuentra determinado por las condiciones materiales de existencia de la sociedad en su conjunto.

Estas reflexiones nos permiten formular una tesis en los siguientes términos:

> Primera tesis: *Cada formación social* crea su propia patología y produce las condiciones sociales para la reproducción de la misma*, en consonancia con el modo de producción prevaleciente (según el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las características de las relaciones sociales dominantes).

En una sociedad donde el modo de producción fundamental es el capitalista, las leyes que rigen su desarrollo proporcionan un marco teórico-metodológico para determinar la manera en que se manifiesta un proceso social como es la salud-enfermedad de la población. Por lo tanto, resulta indispensable conocer las características de dicho modo de producción, que se han expuesto a grandes rasgos en el capítulo anterior.

El análisis efectuado por Marx y Engels se refiere a la sociedad inglesa del siglo XIX, en la que el panorama epidemiológico se encontraba dominado por una patología caracterizada fundamentalmente por enfermedades infecciosas y la desnutrición, conjuntamente con la presencia de un elevado índice de accidentes laborales en la industria. Las causas de dicha patología, tal como lo demostraron Marx y Engels, eran los graves problemas que padecía la población, producto de la forma en que se desarrollaba el capitalismo, que buscaba, al igual que ahora, incrementar la riqueza de unos cuantos contra la miseria de la mayoría de la población conformada por la clase trabajadora.

Marx fue claro cuando señaló que la producción capitalista no conduce solamente al *empobrecimiento* de la fuerza humana de trabajo. *Produce, además, la extenuación y la muerte prematura de la misma fuerza de trabajo* (1973, I:208).

La población trabajaba y vivía en condiciones altamente perjudiciales para su salud: hacinamiento, desnutrición, contaminación ambiental, falta de servicios públicos (agua potable,

*Formación social se refiere a una *sociedad históricamente determinada*, en la que prevalece un modo de producción.

alcantarillado, etcétera), ausencia de medios para la protección del obrero en el lugar de trabajo, falta de descanso, entre otras. Esto tenía que reflejarse necesariamente en la salud de la clase que crea la riqueza social. Las epidemias y diversas enfermedades y accidentes de trabajo encontraban un campo propicio para surgir y desarrollarse en este medio que conformaba la mísera existencia de la clase trabajadora.

Tal patología repercutía también en las demás clases sociales en tanto que no se encontraban aisladas de los efectos del desarrollo capitalista, tal como lo señaló Marx: "El mal [la carestía de vivienda] avanzó de tal modo con el desarrollo de la industria, la acumulación del capital, el crecimiento y el 'embellecimiento' de las ciudades, que de puro miedo a las enfermedades contagiosas, sabiendo que éstas no se detienen ante los 'señores', se dictaron por el parlamento desde 1847 hasta 1864, nada menos que diez leyes de policía sanitaria, y en algunas ciudades como Liverpool, Glasgow, etcétera, la burguesía, aterrada, se apresuró a tomar cartas en el asunto por medio de sus municipalidades" (1973, I:558).

Así, las epidemias, que surgían debido a las condiciones miserables en que vivía la población trabajadora, y los daños ocasionados por la industria, trascendieron al conjunto de la sociedad inglesa, que se vio amenazada por las enfermedades que surgían y diezmaban a la población a medida que avanzaba la consolidación del capitalismo como el modo de producción dominante.

Lo anterior llevó a Marx a decir que "*La tuberculosis y otras enfermedades pulmonares del trabajo son la condición de vida del capitalismo*" (1973, I:403; cursivas nuestras).

He aquí la relación que Marx establece entre la enfermedad vista como un fenómeno social y el modo de producción capitalista que generaba condiciones de vida y de trabajo adversas para la salud, tal como se observaba en la sociedad inglesa. Este planteamiento nos permite afirmar que Marx había integrado a su análisis sociológico de la explotación capitalista las consecuencias de ésta en la salud de la clase trabajadora: presencia de enfermedades antes desconocidas o poco difundidas y mayores y más graves accidentes.

Para apoyar la tesis anterior, Marx da cuenta, por ejemplo, del hacinamiento que existe en las fábricas como un medio para que se desarrollen enfermedades como la tuberculosis: "la ley fabril de 1864 ha blanqueado y limpiado en el ramo de la alfa-

rería, más de 200 talleres, después de *20 años o de toda una vida de ausencia de estas operaciones* (¡he ahí la 'abstinencia' del capitalismo!), en lugares en que se congregaban 27 800 obreros y en que hasta aquí venían respirando, en su agobiador trabajo diurno y no pocas veces nocturno, una atmósfera mefítica que hacía pesar sobre un trabajo relativamente inofensivo la amenaza continua de las enfermedades y la muerte" (1973, I:403).

Empero, la explotación capitalista no sólo se manifiesta en el proceso de trabajo sino que invade la situación de vida del obrero fuera de la fábrica, al arrastrar consigo toda la problemática social que implica el pertenecer a la clase obrera.

De esta manera, las condiciones sociales en que se desarrollan las enfermedades pulmonares no se presentan únicamente en el trabajo, sino que afectan al conjunto familiar y a la sociedad en general, ya que problemas como el hacinamiento se observan también en las viviendas. Marx expone los puntos de vista de autoridades médicas para reafirmar su tesis antes señalada: "El Dr. Embleton, del Hospital de Fiebres Infecciosas de Newcastle, dice: 'no cabe la menor duda de que la causa de que perdure y se extienda el tifus radica en el hacinamiento de seres humanos y en la suciedad de sus viviendas. Las casas en que suelen vivir los obreros están situadas en callejuelas y patios tenebrosos. Son, en lo tocante a luz, aire, amplitud y limpieza, verdaderos modelos de imperfección e insalubridad, una vergüenza para cualquier país civilizado. En estos tugurios duermen revueltos por las noches hombres, mujeres y niños. El turno nocturno de obreros sigue sin interrupción al turno del día, y viceversa, sin dar a las camas siquiera tiempo para enfriarse. *Estas insalubres viviendas tienen poca agua y malos retretes, son sucias, faltas de ventilación, pestilentes*' " (1973, I:561; cursivas nuestras).

La relación que hemos venido analizando (características de la formación social capitalista → enfermedad) no se encuentra aislada en la obra de Marx; se retoma en varias partes: "*Los accidentes son algo sin paralelo en la historia de la maquinaria, lo mismo en extensión que en intensidad* (1973, I:402; cursivas nuestras).

Tal hecho demuestra que en la sociedad en que prevalece el trabajo maquinizado, impuesto por la clase capitalista, importan poco las condiciones en que labora el obrero. Lo que interesa es obtener la máxima plusvalía posible, para lo cual el capital no repara en los daños que inflige a la salud del proletariado.

Marx sitúa el planteamiento anterior dentro de las características del capitalismo, las cuales expusimos en el capítulo anterior: "el capital no pregunta por el *límite de vida de la fuerza de trabajo*. Lo que a él le interesa es, única y exclusivamente, el máximo de fuerza de trabajo que puede movilizarse y ponerse en acción durante una jornada. Y, para conseguir este rendimiento máximo, no tiene inconveniente en abreviar *la vida de la fuerza de trabajo*" (1973, I:208), ya que no coloca los dispositivos necesarios o no dispone de las medidas adecuadas para evitar la insalubridad y proteger al obrero de los procesos de producción nocivos para su salud.

La cita anterior representa un brillante análisis sociológico de la salud-enfermedad de la clase obrera como un proceso que se encuentra determinado por las condiciones sociales de producción impuestas por el capitalismo. Dicho análisis Marx lo repite en el tercer tomo de *El capital*, concretamente en el capítulo V: "Economía en el empleo del capital constante". Esto nos demuestra la profunda preocupación que tenía por las causas sociales de la enfermedad, es decir, por la organización capitalista de la producción que crea las bases para que surjan en forma más frecuente y grave diversas enfermedades y accidentes.

La producción capitalista, dice Marx en ese capítulo, "es, mucho más que cualquier otro régimen de producción, una dilapidadora de hombres, de trabajo vivo, una dilapidadora no sólo de carne y sangre, sino también de nervios y cerebro. Es, en efecto, el derroche más espantoso de desarrollo individual lo que asegura y lleva a efecto el desarrollo de la humanidad en el período histórico que precede directamente a la reconstitución consciente de la sociedad humana" (1973, III:101).

Y continúa diciendo Marx: "*Como la economía a que nos estamos refiriendo* [la capitalista] *obedece toda ella al carácter social del trabajo, es precisamente este carácter directamente social del trabajo lo que engendra este derroche de vida y salud de los obreros*" (1973, III:101; cursivas nuestras).

Dicho aspecto social del trabajo se caracteriza porque los medios de producción (materias primas, instrumentos de trabajo), así como los obreros, se concentran en un número cada vez mayor en locales (fábricas), mientras que en la industria artesanal la familia trabaja casi siempre en la propia vivienda. Por lo tanto, en el sistema fabril, "la maquinaria. . . sólo funciona en manos del trabajo directamente socializado o *colectivo*

[ya que] es *la propia naturaleza del instrumento de trabajo* la que impone como una *necesidad técnica el carácter cooperativo* del proceso de trabajo" (1973, I:316).

Con esto, el obrero individual se convierte en parte del obrero colectivo, quien realiza todas las operaciones necesarias para la elaboración del producto.

Lo anterior conduce a una situación objetiva que daña la salud del trabajador. Se busca el ahorro en la producción de las mercancías a costa de despojar al obrero de las condiciones normales para la conservación de su fuerza de trabajo. Dejemos que Marx hable: "el régimen capitalista de producción. . . *dilapida la vida y la salud del obrero*, considerando la degradación de las mismas condiciones de vida como economía en el empleo del capital constante y, por tanto, como medio para la elevación de la cuota de ganancia" (1973, III:99; cursivas nuestras).

Marx apoyó sus planteamientos anteriores con información empírica proveniente de informes de autoridades médicas e inspectores de fábricas, los cuales mostraban la elevación de los accidentes y enfermedades laborales con la implantación del sistema fabril. Expongamos un ejemplo: "Un solo *scutching mill* (en Kildinan, cerca de Cork) produjo desde 1852 a 1856, seis casos de muerte y 60 mutilaciones graves, accidentes todos que podían haberse evitado con los aparatos más sencillos, gastando solamente unos cuantos chelines. El Dr. White, certifying surgeon de las fábricas de Dawnpatrick, declara, en un informe oficial del 15 de diciembre de 1865: los accidentes de los scutching mills son de lo más espantoso. Se dan muchos casos en que es arrancada del tronco una cuarta parte del cuerpo. Las heridas traen como consecuencia normal la muerte o un porvenir horrible de invalidez y sufrimientos. El desarrollo de las fábricas en esta región multiplicará, naturalmente, estos pavorosos resultados" (1973, I:402-403).

En otra parte de su obra, Marx destaca la protesta de varios médicos contra el sistema fabril que ocasiona la muerte de los trabajadores: "en sus informes testificales ante la Cámara de los Comunes, los doctores Farre, Sir A. Carlisle, Sir B. Brodie, Sir C. Bell, Mr. Guthrie, etcétera, es decir, los médicos y cirujanos más eminentes de Londres, habían declarado que existía *periculum in mora*. Y el Dr. Farre se expresaba en términos todavía más crudos: 'la intervención del legislador es asimismo necesaria para *prevenir la muerte en todas las formas* en que puede sobrevenir prematuramente, y éste [el régimen fabril] es,

sin ningún género de dudas, uno de los métodos más crueles que la ocasionan' " (1973, I:221).

Por su parte, Engels también plantea la relación entre formación social capitalista y enfermedad en varias partes de su libro *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, que es el que analizaremos en este trabajo: "muchos mueren de hambre indirectamente —muchos más directamente— porque la falta de medios suficientes de subsistencia produce enfermedades mortales, porque dicha privación produce en aquellos que son víctimas de ella un debilitamiento tal del cuerpo, que enfermedades que para otros serían ligeras, se hacen para ellos gravísimas y mortales. Los obreros ingleses llaman a eso un *homicidio social y acusan a la sociedad entera de cometer tal delito. ¿Están equivocados?*" (1977:56; cursivas nuestras).

Más adelante Engels reafirma los daños que ocasiona a la salud de los obreros la sociedad capitalista: "si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal, que, necesariamente, caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada o de una maza; si impide a millares de individuos las condiciones necesarias para la vida, si los coloca en un estado en que [apenas] pueden vivir, si los constriñe, con el fuerte brazo de la ley, a permanecer en tal estado hasta la muerte, muerte que debe ser la consecuencia de tal estado; si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos millares de individuos deben caer víctimas de tales condiciones, y, sin embargo, deja que perdure tal estado de cosas, ello constituye, justamente, un asesinato premeditado. . . Probaré ahora que la sociedad, en Inglaterra, consuma cada día, a cada minuto, lo que los diarios obreros ingleses llaman un asesinato social, que ha reducido a los trabajadores a un estado en el que no pueden gozar de buena salud ni vivir mucho; que destruye, pedazo a pedazo, de a poco, la vida de esos trabajadores, y los conduce a la tumba antes de tiempo; debo probar ulteriormente que la sociedad sabe qué nocivo es tal estado para la salud y la vida de los trabajadores, y que, sin embargo, nada hace a fin de mejorar esta condición. Que la sociedad sabe, por sus instituciones, que su modo de proceder no es simplemente homicidio, sino asesinato premeditado, ya lo he probado, puedo alegar documentos oficiales, informes del parlamento y del gobierno, para testificar el hecho del homicidio" (1977:128-129).

Más adelante, Engels vuelve con el mismo planteamiento: "estas diversas enfermedades [viruela, rubeola, tos convulsa o

fiebre escarlatina], *son la necesaria consecuencia del moderno abandono y de la moderna opresión de la clase obrera*" (1977: 142; cursivas nuestras).

Dicho planteamiento lo refuerza con otras observaciones que dan cuenta de que la sociedad capitalista obliga a trabajar a las mujeres que se ven en la necesidad de abandonar a sus hijos a peligros que amenazan su salud y su vida: "estos pobres niños, que mueren de un modo tan terrible (muerte por escaldaduras, caídas en agua caliente, ahogados o quemados, destrozados por caballos o carros), *son simplemente las víctimas de nuestro desorden social, y de la clase propietaria, interesada en mantener tal desorden*" (1977:143; cursivas nuestras).

Lo anterior llevó a Engels a exclamar: "¡Cantidad de enfermedades son producidas simplemente por la horrible avidez de dinero de la burguesía!" (1977:201).

Hemos citado extensamente a Engels porque su estudio sobre los daños a la salud que ocasiona la sociedad capitalista constituye también un análisis sociológico que permite mostrar la relación que venimos examinando: cada tipo de sociedad crea su propia patología.

Las crisis de la sociedad capitalista provocan, sin duda, daños a la salud de la población, tal como lo expresó Engels: "indirectamente, en cada crisis gran número de personas mueren, por enfermedades, etcétera" (1977:122). Este planteamiento lo apoya con información empírica que demuestra la presencia de epidemias cuando se suscitan las crisis comerciales: "En Escocia e Irlanda el tifus domina con una vehemencia que sobrepasa toda idea; en Edimburgo y en Glasgow apareció en 1817, con la carestía; con particular virulencia en 1826 y 1837, después de la crisis comercial, y cada vez, después de cerca de tres años de estragos, dejó siempre algún rastro por cierto tiempo; en Edimburgo, en la epidemia de 1817, fueron atacadas de fiebre 6 000 personas; en la epidemia de 1837, 10 000, y no solamente el número de los enfermos sino también la virulencia de la enfermedad y la proporción de víctimas aumentó en cada repetición de la epidemia" (1977:133).

"Pero parece que el furor de la enfermedad, en estos primeros períodos, fue un juego de niños comparado con la epidemia que siguió a la crisis de 1842. Una sexta parte de los pobres de Escocia fue atacada por esta fiebre, y el mal, a causa de los mendigos que emigraban, pasó con feroz rapidez de un país a otro; no respetó clases sociales; en dos meses hubo tantos enfermos

de fiebre como en los doce años anteriores. En Glasgow enfermó, en 1843, el 12 por ciento de la población; de 32 000 personas atacadas por la fiebre, murió el 32 por ciento, mientras la mortalidad en Manchester y Liverpool, normalmente, alcanza sólo el 1/8 por ciento. La enfermedad hacía crisis el decimoséptimo o decimooctavo día; en este día el paciente se ponía amarillo, lo que probaría, según la autoridad citada, que la causa del mal había que buscarla también en el desgaste físico y en las penurias" (*ibid.*) resultado de la explotación de que era objeto la mayor parte de la población.

Los planteamientos anteriores expuestos por Marx y Engels se refieren a un primer nivel en el análisis de las causas sociales del proceso salud-enfermedad: las características de la formación social (la inglesa) que analizaron los creadores del marxismo y las repercusiones en la salud de la población.

De acuerdo con lo anterior puede afirmarse que la salud-enfermedad es un proceso condicionado históricamente, es decir, adquiere determinadas características según la formación social concreta en que se presenta, que responden a las particularidades que asume el modo de producción capitalista en cierto momento histórico.

Las relaciones sociales predominantes en la sociedad capitalista, que son relaciones de explotación de una clase por otra, configuran, por lo tanto, las características de la morbimortalidad así como las políticas de salud y la práctica médica.

II

Los miembros de una sociedad no se enferman de la misma patología, ni con la misma frecuencia y gravedad; tampoco envejecen con igual rapidez ni tienen una esperanza de vida semejante. La salud-enfermedad como proceso social, así como los demás fenómenos relacionados con ella, se presentan en forma diferencial entre las diversas clases que existen en las sociedades históricamente determinadas. Asimismo, la respuesta a la enfermedad difiere de una clase social a otra.

De acuerdo con lo anterior, podemos plantear otra tesis.

Segunda tesis: *Existe una situación diferencial entre las dos clases sociales fundamentales presentes en las formaciones*

sociales capitalistas (proletariado y burguesía) con respecto a la morbimortalidad, la esperanza de vida y el acceso real a los servicios médicos.

Esta situación diferente se presenta debido a la ubicación de ambas clases en la estructura económica de la sociedad: el proletariado sólo cuenta con su fuerza de trabajo para subsistir, que vende a la clase burguesa como una mercancía; tal hecho lo conduce a trabajar y vivir en condiciones por lo general perjudiciales para su salud. La burguesía, en cambio, al poseer los medios para producir mercancías, rentas e intereses, tiene un nivel de vida diferente (superior en todos los sentidos). Esta realidad objetiva repercute en las características de las enfermedades que padece (las enfermedades infecciosas y la desnutrición son mínimas), y en una menor frecuencia y gravedad de los cuadros patológicos, ya que dispone de los elementos necesarios para evitar o reducir la presencia de la patología de la pobreza: vivienda higiénica y con todos los servicios, alimentación adecuada, servicios médicos oportunos, etcétera. Lo anterior le permite elevar su esperanza de vida en comparación con la de la clase trabajadora.

La situación material del obrero depende de la acumulación capitalista, y aquélla, como sabemos, repercute directa o indirectamente en su salud. Marx señala que "a medida que se acumula el capital, tiene necesariamente que empeorar la situación del obrero, *cualquiera que sea su retribución*, ya sea ésta alta o baja. . . por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza es, en el polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio producto como capital, acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de despotismo y de ignorancia y degradación moral" (1973, I:547).

Las repercusiones concretas de esta ley se manifiestan, por ejemplo, en un mayor número de defunciones en la clase trabajadora en comparación con la burguesía, ya que aquélla tiene menos medios de vida para subsistir. La masa de los nacimientos y *defunciones*, señala Marx, *se halla en razón inversa a la cuantía del salario, es decir, de la masa de medios de vida de que disponen las diversas categorías de obreros* (1973, I:545).

Marx establece aquí una clara relación entre el número de defunciones y la disponibilidad de medios de vida: mientras menores sean éstos, mayor será el número de defunciones. Tales medios de vida son: la vivienda y sus servicios básicos, la com-

posición cualicuantitativa de la alimentación (cantidad y calidad de nutrientes) y el vestido, fundamentalmente.

Pero, ¿cómo logran subsistir grandes grupos de obreros cada vez más golpeados por la acumulación capitalista? Marx señala que "La explicación está en que acuden a recursos heroicos, cuyo secreto sólo el obrero conoce, mermando la ración diaria, comiendo pan de centeno en lugar de pan de trigo; comiendo poca carne o ninguna, y lo mismo manteca y especias; embutiendo a toda la familia en una o dos habitaciones, en las que chicos y muchachas duermen revueltos. . ., ahorrando en el vestido, en la ropa interior, en el jabón y el agua; renunciando a las diversiones de los domingos; en una palabra, sometiéndose a las más dolorosas privaciones" (1973, I:570-571), lo que provoca mayores enfermedades cuya atención oportuna y adecuada es prácticamente imposible.

Las condiciones materiales de existencia del proletariado son la causa verdadera de las *enfermedades nacidas del hambre.* Marx expone un informe del doctor Simon sobre sanidad, el cual, refiriéndose al estado de alimentación de los obreros, señala: "Todo el que haya ejercido la medicina entre gente pobre o pacientes de hospitales, ya sean internos o vivan fuera del establecimiento, sabe cuánto abundan los casos en que *la falta de alimentos provoca o agudiza las enfermedades*. . . Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, hay que tener en cuenta aquí otra circunstancia mucho más decisiva. . . Debe recordarse que el organismo sólo a duras penas tolera que se le prive de sustancias alimenticias y que, por lo general, a la penuria precede toda otra clase de privaciones. Mucho antes de que el déficit alimenticio adquiera una importancia higiénica. . . la casa del paciente se habrá visto despojada de todo confort material. El vestido y la calefacción dejarán todavía más que desear que el mismo alimento. La familia estará expuesta, sin defensa, a todas las inclemencias del tiempo; el espacio habitable se verá reducido a proporciones que *son pasto de enfermedades* o un incentivo para ellas; el menaje de casa y los muebles habrán desaparecido casi sin dejar rastro, y hasta la misma limpieza resultará costosa y casi inasequible. Y si, por un sentimiento de dignidad, aún se intenta conservarla, cada uno de estos intentos representará un nuevo tormento de hambre. La vivienda se instalará allí donde el techo resulte más barato; en barrios en que la policía sanitaria recolecta los frutos más insignificantes, con desagües espantosos, circulación escasa, basura abundante,

poca agua y luz. Tales son los peligros sanitarios a que inevitablemente se halla abocada la pobreza, cuando los pobres no pueden comer siquiera lo estrictamente indispensable. Y si todos estos males, sumados, envuelven un peligro tremendo para la vida humana, la simple escasez de alimento es ya de suyo algo verdaderamente espantoso. . . Ideas aterradoras, sobre todo si se tiene en cuenta que la pobreza a la que nos referimos no es la pobreza de la ociosidad, achacable a quien la padece. *Trátase de la pobreza de los trabajadores*" (1973, I:557; cursivas nuestras).

La exposición anterior expresa claramente la relación entre las condiciones miserables de vida a que se redujo a la clase obrera inglesa durante gran parte del siglo XIX (hacinamiento, desnutrición, insalubridad, vestido insuficiente o inapropiado, falta de medios para la limpieza individual y de la vivienda) y la patología nacida de dicha pobreza.

Lo anterior repercute negativamente en la esperanza de vida de la clase trabajadora. La reducción del número de años que vive el proletariado, en comparación con la clase pudiente, fue observada por Marx: "el capital consume la fuerza de trabajo con tanta rapidez, que un obrero de edad media es ya, en la mayoría de los casos, un hombre más o menos caduco. Se le arroja al montón de supernumerarios o se le rebaja de categoría. . . el Dr. Lee, funcionario de Sanidad de Manchester, ha comprobado que en esta ciudad la duración media de la vida, en la clase pudiente, son 38 años y en la clase obrera solamente 17. En Liverpool, es de 35 años para la primera y de 15 para la segunda. De donde se sigue que *la clase privilegiada tiene una licencia de vida* (have a lease of life) *más del doble mayor que la que disfrutan sus conciudadanos menos pudientes*" (1973, I:543-544; cursivas nuestras).

No es de extrañar la baja esperanza de vida del proletariado, que se debía a que sus miembros se incorporaban a la vida productiva desde los 6, 7 u 8 años, obligados por las exigencias del capital de extraer la máxima plusvalía al menor costo posible.

La explotación capitalista no sólo se manifiesta en los daños a la salud del obrero sino que se traslada al núcleo familiar en el que la población infantil, por ejemplo, sufre las consecuencias de las condiciones de trabajo y de vida impuestas a sus padres. Tal situación se concreta en una menor esperanza de vida en los hijos de los obreros, debido a las precarias condiciones en que surgen a la escena social: condiciones de explotación de la clase trabajadora por la burguesa.

Al respecto, Marx habla de "*la enorme mortalidad de niños de obreros en edad temprana*. En Inglaterra hay 16 distritos en los que, de cada 100 000 niños que nacen mueren al cabo del año, por término medio, 9 000 (en uno de estos distritos, la cifra media es de 7 047 solamente); 24 distritos en los que la cifra de mortalidad es superior a 10 000, pero inferior a 11 000; 39 distritos, en los que oscila entre 11 000 y 12 000; 48 distritos en los que excede a 12 000 sin llegar a 13 000; 22 distritos en los que excede de 20 000; 25 distritos en los que la mortalidad rebasa la cifra de 21 000; 17, en los que excede de 22 000; 11, en los que pasa de 23 000; en Hoo, Wolverhampton, Ashton-under-Lyne y Preston, la mortalidad infantil pasa de 24 000; en Nottingham, Stockport y Bradford, rebasa la cifra de 25 000; en Wisbeach, la de 26 000 y en Manchester la de 26 125 (*Sixth Report on Public Health*, Londres, 1864:34). Según demostró una investigación médica oficial abierta en 1861, estas elevadas cifras de mortalidad se deben principalmente, si prescindimos de circunstancias de orden local, *al trabajo de las madres fuera de la casa*, con el consiguiente abandono y descuido de los niños, alimentación inadecuada e insuficiente de éstos, empleo de narcóticos, etcétera, aborrecimiento de los niños por sus madres, seguido de abundantes casos de muerte provocada por hambre, envenenamiento, etcétera" (1973, I:326-327).

Como podemos darnos cuenta, Marx relaciona la mortalidad infantil elevada con las condiciones sociales en que trabaja y vive la clase proletaria (trabajo de la madre fuera del hogar, falta de alimentación), las cuales repercuten a su vez en esferas subjetivas, por ejemplo, el aborrecimiento de los hijos por sus padres que incide en una menor atención a los niños.

Las estadísticas oficiales presentan la tasa de mortalidad infantil casi siempre para toda la población. Tal hecho permite ocultar una realidad objetiva: la existencia de una situación diferente respecto de la mortalidad infantil (así como de la mortalidad general y por causas específicas) y de la esperanza de vida entre el proletariado y la burguesía.

Esta realidad, innegable cuando se analiza la mortalidad infantil por clases sociales, es producto de la ubicación estructural de ambas clases en la sociedad capitalista. La clase proletaria, como ya se apuntó, cuenta sólo con su fuerza de trabajo para subsistir, en tanto que la capitalista es dueña de los medios de producción.

Esto trae como consecuencia que la población infantil obre-

ra padezca una tasa de mortalidad más elevada que la que se observa en los niños pertenecientes a la burguesía, como lo han demostrado diversos estudios empíricos.

Engels presenta también información empírica para apoyar el planteamiento de que existe una situación diferencial en la esperanza de vida así como en las tasas de mortalidad infantil y general entre las dos clases sociales: burguesía y proletariado. "En Edimburgo, en el año 1838-39, se tuvo un muerto por cada 39 habitantes, mientras que en la ciudad vieja, en 1831, se tuvo uno por cada 22; en Glasgow, según el Dr. Cowan (*Vital Statistics of Glasgow*), la media, después de 1830, fue de uno sobre 30; en cada año en particular, uno sobre 22 hasta 24. Se prueba, por todos estos datos, que *la enorme disminución de la duración media de la vida se observa principalmente en las clases obreras, y que la media total mejora gracias a la menor mortalidad en las clases altas o medias.** Uno de los últimos datos sobre esto, es el siguiente del Dr. P. H. Holland, de Manchester, el cual, en misión oficial, hizo una encuesta, en el suburbio de Manchester, Chorlton-on-Medlock" (Engels 1977:140; cursivas nuestras).

El doctor Holland, continúa diciendo Engels, clasifica las casas y las calles en tres categorías y encuentra la siguiente proporción en la mortalidad:

Primera categoría de calles; casas					I	categoría, mortalidad		1	sobre	51
"	"	"	"	"	II	"	"	1	"	45
"	"	"	"	"	III	"	"	1	"	36
Segunda categoría de calles; casas					I	categoría, mortalidad		1	sobre	55
"	"	"	"	"	II	"	"	1	"	38
"	"	"	"	"	III	"	"	1	"	35
Tercera categoría de calles; casas					I	categoría, mortalidad		1	sobre	25
"	"	"	"	"	II	"	"	1	"	35
"	"	"	"	"	III	"	"	1	"	25

Fuente: *Report of the Commission of Inquiry into the State of Large Towns and Populous Districts. First Report, 1844, Appendix.*

"Por otras estadísticas, dadas por Holland —insiste Engels— resulta que la mortalidad, en las calles de la segunda clase, es del 18% y en las de la tercera clase, del 68% más que en las de la primera clase; la mortalidad, en las casas de la segunda clase, es

*Engels (1977:31) denomina clases medias a la clase poseedora, de modo semejante a la *bourgeoisie* francesa.

del 31% y en las de la tercera clase del 78% más que en las de la primera; que la mortalidad, en las calles que fueron reparadas, disminuyó en un 25%." Termina el autor con una observación bastante clara para un burgués inglés. "Si comprobamos que la mortalidad, en determinada categoría de calles, es más alta que en otra, y que en ciertas categorías, es doble que en otras, si es invariablemente alta en las calles que están en las peores condiciones, e invariablemente baja en aquellas que se encuentran en buenas condiciones, podemos inferir que multitud de personas, centenares de vecinos nuestros son aniquilados (*destroyed*) anualmente, por falta de las más elementales medidas de previsión. El informe sobre el estado de salud de la clase trabajadora contiene datos que *prueban* lo mismo. En Liverpool, en 1840, *la duración media de la vida en la alta burguesía (Gentry, Professional men, etc.) era de 35 años; en la clase comercial y de los artesanos en mejor condición, de 22; de los obreros, jornaleros y de la clase inferior, generalmente sólo de 15 años*" (*ibid.*: 140-141; cursivas nuestras).

Sin duda, la baja esperanza de vida de la clase obrera es producto de las innumerables enfermedades que padece, las que a su vez se generan por las deterioradas condiciones de trabajo y de vida impuestas por el desarrollo capitalista.

Engels realiza un magistral análisis de lo anterior. Expongamos algunas de sus consideraciones: "Ha sido probado ya, ampliamente, que las habitaciones de los trabajadores, en las partes peores de las ciudades, junto con la antigua condición de vida de esta clase, provocan gran cantidad de enfermedades. . . Que la atmósfera mala de Londres, especialmente en los barrios obreros, favorece al más alto grado la tuberculosis, lo demuestra el aspecto demacrado de mucha gente que encontramos en la calle" (Engels 1977:131). Y continúa diciendo: "la fiebre tifoidea se encuentra en los barrios obreros de todas las grandes ciudades, así como en las calles mal construidas y mal tenidas de las más pequeñas regiones, siendo su difusión mayor en los barrios malos" (*ibid.*:132): "Si se recuerda la condición en que viven los trabajadores, si se piensa cómo están repletas sus viviendas, cómo cada rincón está lleno de hombres; que enfermos y sanos duermen en la misma pieza, en un solo sitio, se maravilla uno de que una enfermedad infecciosa, como esta fiebre, no se extienda todavía más" (*ibid.*:134).

"Hay otra serie de enfermedades —señala Engels— que tienen su origen más en fallas de la nutrición, que en la vivienda

de los obreros. . . Casi todos los trabajadores tienen, en mayor o menor grado, un estómago débil, y sin embargo, deben seguir, obligadamente, la misma dieta que fue causa de sus males. Y aun cuando conocieran la causa ¿cómo podrían proveerse de alimentos convenientes, sin alcanzar plenamente otras condiciones de vida, sin ser educados en otra forma? A causa de estas malas digestiones, ya en la infancia se desarrollan nuevas enfermedades. La escrofulosis está generalmente difundida entre los obreros, y los padres escrofulosos tienen hijos escrofulosos. . . Un segundo resultado de la insuficiente nutrición del cuerpo, durante el crecimiento, es el raquitismo (enfermedad inglesa, excrecencias nudosas en las articulaciones) que se encuentra muy a menudo entre los hijos de los obreros. La calcificación de los huesos está retardada, sobre todo la formación de los huesos se detiene. . . El abandono a que está condenada la gran masa de los hijos de los obreros, deja un sello indeleble y su consecuencia es el debilitamiento de toda la generación obrera" (1977:134-135).

"Es necesario tener en cuenta —prosigue Engels— además, lo inadecuado de la vestimenta de esta clase, la imposibilidad, cada vez mayor, de protegerse de los enfriamientos, de la necesidad de trabajar hasta que lo permita la salud, de la miseria creciente de la familia en los casos de enfermedades, de la falta de asistencia médica" (*ibid.*:135-136).

"Existen todavía otras causas que debilitan la salud de gran número de trabajadores. Ante todo, la bebida; todas las seducciones, todas las posibles tentaciones se juntan para empujar al obrero a la pasión de la bebida. El aguardiente es para los trabajadores casi la única fuente de goces, y todo conspira para que se estreche el círculo a su alrededor. . . Todas las enfermedades, que derivan de las condiciones de vida del obrero, son aceleradas por el alcoholismo, así, el desarrollo de las enfermedades crónicas y del bajo vientre, como el origen y difusión del tifus, son favorecidas por él al más alto grado" (*ibid.*:136-137).

En cuanto al saneamiento del ambiente en que vive el obrero, Engels lo describe en los siguientes términos: "las inmundicias y charcas, que existen en los barrios obreros de las grandes ciudades, producen las peores consecuencias para la salud pública, porque exhalan los gases portadores de las enfermedades. . . Es verdaderamente indignante la forma en que es tratada, por la moderna sociedad, la masa de los pobres. Se la lleva a las grandes ciudades, donde respira un aire más malo

que en su lugar natal; se la exila en barrios que, por su construcción, están peor ventilados que otros; le son negados todos los medios para la limpieza... estando los ríos tan infestados, que ya no pueden servir a los efectos de la limpieza; se la obliga a tirar en la calle todos los residuos y desperdicios, el agua sucia, y, a menudo, las más nauseabundas inmundicias y el estiércol, al mismo tiempo que se impiden todos los medios de actuar de otro modo" (*ibid.*:130).

La explotación capitalista se manifiesta también, como ya lo hemos apuntado, en la población infantil, que es la que más resiente las precarias condiciones de existencia a que es reducida la clase obrera por el proceso de acumulación de capital.

Engels proporciona una descripción de tal hecho y sus resultados concretos: mayor tasa de mortalidad en los hijos de los obreros: "las listas de la mortalidad, principalmente, suben a cifras altas, por el gran número de niños pequeños que mueren en la clase obrera. El cuerpo delicado de un niño resiste menos las influencias desfavorables de una baja condición de vida; el abandono a que está sujeto el niño en esta clase, si ambos progenitores trabajan, o si uno de los dos ha muerto, hace sentir rápidamente sus efectos, y no debe asombrar que, como sucede en Manchester, según las estadísticas mencionadas, *muere antes de los cinco años más del 57% de los niños de la clase obrera, mientras sólo muere el 20% en las clases superiores*" (datos tomados de *Factories Inquiry Commission's Report, 3rd. vol. Report of Dr. Hawkins on Lancashire*, citado por Engels 1977: 141; cursivas nuestras).

En relación con el envejecimiento prematuro, que es una expresión concreta del desgaste de la fuerza de trabajo consumida por el capital, Engels expone lo siguiente: "Isnillie, médico cirujano en Glasgow, que especialmente atendía obreros de fábrica, dice igualmente que ellos, a los cuarenta años, son ya viejos *(old age)*... En Manchester —continúa Engels— *esta vejez precoz de los obreros es tan general, que todo hombre de cuarenta años parece tener diez o quince años más, mientras las clases acomodadas, tanto hombres como mujeres, conservan muy bien su aspecto*" (*ibid.*:195; cursivas nuestras).

La situación que vive la clase proletaria en su lugar de trabajo también repercute en su salud, ya que al capital le interesa obtener la máxima plusvalía al menor costo posible. Para ello no tiene inconveniente en mantener al obrero en condiciones insalubres que provocan enfermedades y accidentes.

Marx describe el ambiente laboral y sus repercusiones en la salud de la siguiente manera: "Todos los sentidos se sienten perturbados por la elevación artificial de la temperatura, por la atmósfera cargada de desperdicios de material, por el ruido ensordecedor, etcétera. Y no hablemos del peligro que supone tener que trabajar y circular entre la maquinaria apretujada, que produce sus partes industriales de batalla con la periodicidad de las estaciones. La tendencia a *economizar los medios sociales de producción*, tendencia que bajo el sistema fabril, madura como planta de estufa, se convierte, en manos del capital, en un *saqueo sistemático contra las condiciones de vida del obrero durante el trabajo*, en un robo organizado de espacio, de luz, de aire y de los medios personales de protección contra los procesos de producción malsanos o insalubres, y no hablemos de los aparatos e instalaciones para comodidad del obrero. ¿Tiene o no razón Fourier cuando llama a las fábricas 'presidios atenuados'?" (1973, I:352-353).

Lo anterior conduce necesariamente al surgimiento de enfermedades y accidentes de trabajo, muchos de ellos desconocidos o poco frecuentes antes de la implantación del régimen fabril. "Se crea la base y [se] da el impulso para que se forme una *patología industrial*", señala Marx (1973, I:296), que padece, naturalmente, el obrero.

El interés de Marx por conocer la forma en que las condiciones de trabajo y de vida afectan la salud del trabajador se manifiesta también en la *encuesta obrera* que elaboró y que se incluye en este libro.

Las condiciones materiales de existencia de amplios sectores del proletariado, impuestas por el capital, limitan o impiden no sólo el acceso a medios de vida para evitar o reducir las enfermedades (vivienda higiénica, alimentación y vestido apropiados). Tales condiciones le impiden también disponer de una atención médica oportuna y adecuada para hacer frente a la patología de la pobreza y a la que resulta del proceso de producción (patología industrial), las cuales se encuentran íntimamente relacionadas. Lo contrario sucede en la clase burguesa, que posee los medios para retrasar la enfermedad o evitar que ésta se complique y deje secuelas incapacitantes.

Engels presenta las dificultades de la clase trabajadora para recibir atención médica: "Otra clase de males, para la clase trabajadora, reside en la imposibilidad de procurarse asistencia médica conveniente. Es cierto que gran número de institutos

benéficos buscan ayudar a la gran masa de los trabajadores, como, por ejemplo, el hospital de Manchester, que, anualmente, en parte recoge y en parte socorre con el consejo del médico y con medicinas, a 22 000 enfermos; pero ¿qué es todo esto, para una ciudad donde, según el informe de Gaskell, tres cuartas partes de los habitantes necesitan anualmente socorro médico? Los médicos ingleses cobran altos honorarios y los obreros no están en condición de pagarlos. Nada pueden hacer, y se ven obligados a recurrir a charlatanes y echar mano a medicinas baratas de curandero, que con el tiempo les reportan más daño que beneficio" (1977:137).

Cuando acuden a médicos de las fábricas los obreros se enfrentan, por lo general, a una realidad: al caer en las garras del capital y convertirse en asalariados, los médicos se encuentran supeditados a las decisiones del patrón, viéndose obligados, por lo tanto, a cuidar los intereses del capital. Marx y Engels lo destacaron con toda claridad: "la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al *médico*, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados" (Engels s/f:22; cursivas nuestras).

Marx da pruebas concretas de lo anterior: "según confesión de los propios inspectores de fábrica, el descenso, a veces verdaderamente repentino, que en las estadísticas inglesas de los últimos 20 años sorprende en cuanto a las cifras de los muchachos menores de 13 años empleados en las fábricas, era en gran parte obra de los médicos encargados de certificar, los cuales registraban la edad de los niños plegándose a la codicia de explotación de los capitalistas" (Marx 1973, I:325-326).

Las consecuencias de todas las limitaciones o carencias que tiene la clase proletaria se concretan, sin lugar a dudas, en su salud: existe "un general debilitamiento físico de los obreros. Entre ellos se encuentra la gente menos sana, menos bien constituida, y menos fuerte... [Los obreros industriales] son casi todos débiles, de osatura angulosa, pero no fuerte, flacos, pálidos, consumidos por la fiebre... Sufren casi todos de dispepsia, y son por esto, en mayor o menor grado, hipocondríacos y de genio áspero y difícil. Sus debilitados cuerpos no están en condiciones de resistir las enfermedades, y son atacados siempre. Por esto *los obreros envejecen prematuramente y mueren jóvenes*. Las estadísticas de mortalidad dan de esto una prueba incontrastable", señala Engels (1977:138-139; cursivas nuestras).

El envejecimiento y la muerte prematuros de los obreros encuentra su explicación en la forma en que se organiza la producción capitalista, que responde a un interés fundamental: obtener la máxima ganancia posible, para lo cual, dice Marx, "no tiene inconveniente en *abreviar la vida de la fuerza de trabajo*".

Los análisis efectuados por Marx y Engels permiten concluir que las clases sociales tienen distinta forma de enfermarse; también difiere el tipo de patologías que predominan en cada una de ellas y la frecuencia con que se enferman. Asimismo, son diferentes las tasas de mortalidad general e infantil, así como la edad en que se inicia el envejecimiento. Todo ello conduce a que la esperanza de vida difiera de una clase a otra, siendo más reducida en la clase obrera en comparación con la de la clase burguesa.

Como ya se ha expuesto, esta situación diferente que tienen ambas clases sociales ante la enfermedad y la muerte es producto de las condiciones materiales de trabajo y de vida impuestas por las relaciones sociales de producción dominantes, que son, en esencia, relaciones de explotación. Éstas permiten y alientan la obtención de la máxima ganancia a costa de la salud de los trabajadores y sus familias al limitarles, o negarles, los medios necesarios para su adecuado desarrollo físico que permita su reproducción como especie.

Al capital mucho menos le interesa el desarrollo intelectual, artístico y espiritual de los obreros, en la medida en que no es un elemento decisivo para la puesta en marcha de la producción. Marx fue claro al respecto: "el obrero no es, desde que nace hasta que muere, *más que fuerza de trabajo*; por tanto, todo su tiempo disponible es, por obra del derecho, *tiempo de trabajo* y pertenece, como es lógico, *al capital para su incrementación*. Tiempo para formarse una cultura, para perfeccionarse espiritualmente, para cumplir las funciones sociales del hombre, para el trato social, para el libre juego de las fuerzas físicas y espirituales de la vida humana. . .. ¡todo una pura *pamema*!" (1973, I:207).

III

El modo de producción capitalista cobra realidad en las distintas formaciones sociales que han existido desde que surgió a la

escena de la historia social. Dentro de cada una de ellas el modo de producción capitalista se concreta en las diversas ramas de la economía y en las fábricas pertenecientes a éstas, donde los obreros se incorporan al proceso productivo según el área o departamento en que les corresponde trabajar, según las disposiciones del capital.

Por lo tanto, el modo de producción capitalista se manifiesta de diversas formas, de acuerdo con el lugar y el tiempo de que se trate; de ahí derivan las condiciones históricas de su desarrollo, que es distinto de una a otra formación social, y dentro de un mismo sector de la producción existen diferencias, así como dentro de industrias pertenecientes a una misma rama de la economía.

Lo anterior se debe al desarrollo desigual de las fuerzas productivas, al distinto grado de concentración y de composición orgánica del capital y a las diversas condiciones técnicas en que se efectúa el proceso productivo. De ello se deduce que aun cuando la fuerza de trabajo se consume, se explota por el capital, su grado de explotación varía según el tipo y la cantidad de plusvalía que se extraiga. Esto, sin duda, repercute en forma distinta en la salud-enfermedad de la clase obrera, ya que ésta no es un todo monolítico; en su interior existen sectores que trabajan y viven de distinta manera y se incorporan a la lucha de clases también de forma diversa.

Tal situación demuestra la complejidad del análisis de la salud-enfermedad cuando se analiza este proceso considerando los diversos grupos que componen a la clase trabajadora. Ello permitirá, por otra parte, orientar las políticas y estrategias de acción encaminadas al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida que dañan la salud del proletariado.

De acuerdo con lo expuesto podemos plantear una:

> Tercera tesis: *Dentro del proletariado existe una situación diferente entre los diversos sectores que lo componen con respecto a las características de la morbimortalidad, la esperanza de vida, el nivel de conciencia sobre los problemas de salud y el acceso real a los servicios médicos.*

Tales diferencias se deben a que los miembros de la clase obrera:

1] trabajan en distintas ramas de la economía;

2] se insertan en el proceso productivo de diversas manera (según el tipo de ocupación y las condiciones de trabajo existentes);

3] perciben un salario cuyo monto (derivado en gran medida de lo anterior) es diferente, lo cual repercute a su vez en la reproducción de la fuerza de trabajo (vivienda, alimentación, vestido);

4] las características específicas de la legislación para regular las relaciones capital-trabajo varían de uno a otro sector del proletariado, y

5] el nivel educativo, el nivel de conciencia de clase y las características culturales difieren también de un grupo a otro dentro del proletariado.

Marx y Engels observaron la situación diferente en que se consume la fuerza de trabajo por el capital y sus repercusiones en la salud-enfermedad y la esperanza de vida de la clase obrera. Aunque en sus análisis no establecieron expresamente las diferencias en la salud-enfermedad según las causas que acabamos de exponer, sus consideraciones y observaciones de la realidad apuntan hacia ello.

El desarrollo del capitalismo obligó a la mecanización del proceso productivo en las grandes industrias, lo que condujo a un uso intensivo de la fuerza de trabajo "que amenaza con destruir —dice Marx— la salud de los obreros y, por consiguiente, *la propia fuerza de trabajo*. . ." (1973, I:344), ya que "la intensidad creciente del trabajo supone un despliegue mayor de trabajo dentro del mismo espacio de tiempo" (*ibid.*:438). Tal situación es producto de la mecanización de las distintas fases del proceso productivo, que repercute no solamente en el aspecto físico de los obreros al obligarlos a trabajar en forma más intensa, sino que influye en el sistema nervioso. Esto lo habían señalado también Marx y Engels: "el trabajo mecánico afecta enormemente al sistema nervioso, ahoga el juego variado de los músculos y confisca toda la libre actividad física y espiritual del obrero", señala Engels (citado por Marx 1973, I:349-350).

Los resultados de un trabajo mecanizado que consume mayor energía física y psíquica se traducen en una menor esperanza de vida: "los obreros de la gran industria son precisamente los que acusan las cifras de vida más cortas" (Marx 1973, I:543).

Marx dedica dos apartados de su obra (*El capital*, vol. I) a indagar las condiciones de trabajo y de vida de los sectores del

proletariado más golpeados por el capital, y sus repercusiones en la salud y la esperanza de vida ("Ramas industriales inglesas sin límite legal de explotación", capítulo "La jornada de trabajo"; "Las capas peor pagadas del proletariado industrial inglés", capítulo "La ley general de la acumulación capitalista").

Del primer apartado podemos extraer lo siguiente para dar cuenta de la situación diferencial ante la enfermedad y la muerte dentro del proletariado. "El Dr. Greenhow declara que el límite de vida en los distritos alfareros de *Stoke-upon-Trent* y *Wolstanton* es extraordinariamente corto. Aunque en el distrito de Stoke sólo trabajan en esta industria el 30.6% y en el de Wolstanton el 30.4% del censo masculino superior a veinte años, *más de la mitad* de los hombres de esta categoría que mueren de tuberculosis en el primer distrito, y hacia unos 2/5 de los que fallecen de las mismas enfermedades en el segundo distrito mencionado son alfareros. El Dr. Boothroyd, médico de Hanley, declara: 'Cada nueva generación de alfareros es más raquítica y más débil que la anterior.' Y lo mismo declara otro médico, Mr. McBean: 'En los 25 años que llevo ejerciendo la profesión entre los alfareros, he observado cómo progresaba a ojos vistas la degeneración de esta clase, comprobada en el descenso de peso y talla' " (Marx 1973, I:189-190).

"A partir de 1845, la manufactura de cerillas —dice Marx— comienza a propagarse rápidamente por Inglaterra. . . y con ella el trismo, enfermedad que un médico vienés descubre ya en 1845 como característica de los cerilleros. . . La manufactura cerillera tiene tal fama de malsana y repugnante, que sólo le suministra niños, 'niños andrajosos, hambrientos, abandonados y sin educar', la parte más desamparada de la clase obrera, viudas medio muertas de hambre" (*ibid.*:191).

Con respecto a los panaderos, Marx señala que "el informe de la Comisión investigadora clasifica a los oficiales panaderos entre los obreros de vida corta, pues, después de escapar con vida de las enfermedades infantiles que diezman todos los sectores de la clase trabajadora, rara vez llegan a los 42 años" (*ibid.*: 195).

En cuanto al herrero Marx cita el informe del doctor Richardson: "El herrero se levanta antes de que amanezca. . .: come, bebe y duerme como ningún otro hombre, y es cierto que, ateniéndonos al puro aspecto físico, la situación del herrero sería inmejorable, si no trabajase más de lo debido. Pero, sigamos sus huellas en la ciudad y veamos el agobio de trabajo

que pesa sobre sus hombros fornidos y el lugar que ocupa esta profesión en los índices de mortalidad de nuestro país. En Marylebone (uno de los barrios más populosos de Londres) muere todos los años un 31 por 100 de herreros, o sea, 11 hombres, cifra que rebasa el grado medio de mortalidad de los hombres adultos en Inglaterra. Esta ocupación, que es casi un arte instintivo de la humanidad, impecable de por sí, se convierte por el simple exceso de trabajo, en aniquiladora del hombre que la desempeña [al que] se le obliga a descargar tantos o cuantos martillazos más, a andar tantos o cuantos pasos más, a respirar tantas o cuantas veces más durante el día, *y todo ello junto hace que su desgaste diario de vida sea una cuarta parte mayor. . .* viviendo 37 años en vez de vivir 50" (*ibid.*:199).

Con respecto a las trabajadoras de los "lavaderos al aire libre", Marx también proporciona información que permite demostrar la existencia de algunas enfermedades características de este tipo de trabajo y la existencia de un nivel más bajo de salud en comparación con otros grupos de trabajadores. Al respecto "un médico declara: mi experiencia en el tratamiento de las enfermedades de estas obreras me obliga a poner de manifiesto que *su estado de salud es muy inferior al de las hilanderas de algodón* (¡y en sus súplicas al parlamento, el capital las presentaba como *rebosantes de salud*!). Sus enfermedades más notorias son la tisis, la bronquitis, las enfermedades uterinas, el histerismo en sus formas más espantosas y el reumatismo. Todas estas dolencias provienen, a mi juicio, directa o indirectamente, del aire caliginoso que respiran en los lugares de trabajo y de la carencia de vestidos calientes que las protejan de la atmósfera fría y húmeda, al volver a sus casas durante los meses de invierno" (1973, I:236).

En relación con el apartado "Las capas peor pagadas del proletariado industrial inglés", del capítulo "La ley general de la acumulación capitalista", Marx expone investigaciones para mostrar la existencia de una situación distinta en la salud-enfermedad de estas capas en comparación con la de otros grupos de trabajadores.

"En 1863 —señala Marx— el Privy Council ordenó que se abriese una investigación sobre el estado de penuria del sector peor pagado de la clase obrera inglesa. El Dr. Simon, funcionario médico del Consejo, eligió para esta misión al mismo Dr. Smith, citado más arriba. Su investigación se extiende, de una parte, a los obreros agrícolas y de otra a los tejedores de seda,

costureras, guanteros en piel, calceteros, tejedores de guantes y zapateros. Estas últimas categorías son, si se exceptúan los calceteros, exclusivamente urbanas. La investigación adoptó como norma el elegir, dentro de cada categoría, las familias más sanas y en mejor situación, relativamente" (1973, I:555).

"El resultado general —continúa Marx— fue que 'solamente en *una* de las clases de obreros investigadas la dosis de nitrógeno rebasaba ligeramente el *mínimo* absoluto por debajo del cual se producen enfermedades nacidas del hambre; que en *dos* clases existía déficit —en una de ellas, un déficit *muy grande*— tanto de sustancias portadoras de carbono como de alimentos nitrogenados; que, entre las familias de obreros agrícolas examinadas, más de una quinta parte ingería menos de la dosis indispensable de carbono y más de la tercera parte menos de la dosis indispensable de nitrógeno y, finalmente, que en tres condados (Berkshire, Oxfordshire y Somersetshire) existía, por término medio, déficit de nitrógeno en la alimentación'. De los obreros agrícolas, los peor alimentados eran los de Inglaterra, la parte más rica del Reino Unido. Entre los miembros de la familia de estos jornaleros, los más desnutridos eran, generalmente, la mujer y los niños, pues 'el marido tiene que comer para poder trabajar'. Pero todavía era peor la penuria reinante entre las categorías de obreros urbanos investigadas. 'Están tan desnutridos que necesariamente tienen que presentarse muchísimos casos de cruel y malsana privación' (¡he ahí la 'abstinencia' del capitalista, que en efecto se *abstiene de pagar* hasta los víveres indispensables para que los brazos que trabajan para él puedan llevar una existencia meramente vegetativa!)" (1973,I:555-556).

Según la investigación citada, "Las categorías peor alimentadas eran las costureras, los tejedores en seda y los guanteros en piel" (*ibid.*:557). Mayores datos al respecto se presentarán en el tercer capítulo.

Lo anterior demuestra una vez más que Marx había incorporado a su análisis de la explotación capitalista las repercusiones de ésta en la salud de la clase trabajadora, diferenciándola según capas o sectores.

Por su parte, Engels también dio cuenta de esta situación diferencial que tienen los diversos grupos de trabajadores ante la enfermedad.

En *La situación de la clase obrera en Inglaterra* señala esta realidad: "*encontramos algunas ramas de trabajo que, a causa*

de su carácter, son extraordinariamente dañosas para la salud. Ciertas operaciones implican continua presión de utensilios contra el pecho y producen frecuentemente la tisis; otras, como por ejemplo el limar, impiden el general desarrollo del cuerpo y producen incomodidades en el bajo vientre; el tallado de huesos (para mangos de cuchillos) produce dolores a la cabeza y enfermedades al hígado, y en las muchachas, muchas de las cuales están ocupadas en este trabajo, la clorosis. Pero el trabajo más insalubre es la limpieza de aldabas y tenedores, que, especialmente cuando se hace sobre piedras secas, predispone fatalmente a la muerte prematura. La insalubridad de este trabajo se debe a la posición encorvada, por la que son oprimidos el pecho y el estómago, pero, especialmente, a la gran cantidad de polvo metálico y penetrante que se desprende en la acción de pulir, llena la atmósfera, y es necesariamente aspirado" (p. 237; cursivas nuestras).

"Los que pulen a seco —continúa Engels— llegan apenas a los treinta y cinco años, los que pulen con líquido, rara vez a 45. El doctor Knight, de Sheffield, dice: "Puedo hacer patente, en cierto modo, la infamia de este oficio, declarando que los más fuertes bebedores son, entre los obreros del pulido, los que viven más tiempo, porque faltan al trabajo. En total hay en Sheffield 2 500 obreros del pulido. Cerca de 150 (80 hombres y 70 muchachos) son los que pulen tenedores —éstos mueren entre los 28 y los 32 años; los que pulen navajas, usando tanto el sistema seco como el húmedo, mueren entre los 40 y los 45 años, y los que pulen cuchillos a húmedo, mueren entre los 40 y los 50 años' " (*ibid.*:239-240).

Más adelante insiste en que "en relación con *la especie de trabajo y su influencia sobre la salud*, pocos cambios se han producido desde la aparición del movimiento industrial" (*ibid.*: 245; cursivas nuestras), de tal manera que diferentes trabajos pueden provocar diferentes enfermedades y una esperanza de vida también distinta.

Engels proporciona información concreta sobre el particular: "las deformaciones de la pelvis y partes contiguas, dolorosas y a veces mortales, derivan del trabajo de las mujeres en las minas. Además de estas lesiones locales, los mineros sufren todavía una serie de enfermedades especiales, que coinciden más o menos con las de los otros obreros de minas, y que *son una consecuencia del modo de trabajo*. Ante todo, sufre el bajo vientre; cesa el apetito, se presentan en el mayor número de los

casos, dolores de estómago, vómitos, náuseas, también sed ardiente, que puede ser saciada solamente con el agua sucia y a veces tibia de la mina; el acto de la digestión está trastornado, y las otras enfermedades se suceden fácilmente. Enfermedades del corazón, especialmente hipertrofia, inflamaciones del corazón y del pericardio, contracciones aurico-ventriculares, y del comienzo de la aorta, han sido denunciadas como males frecuentes entre los mineros, y explicadas fácilmente por el exagerado trabajo. Lo mismo dígase de las lesiones casi generales, que son consecuencia directa del esfuerzo muscular desorbitado. En parte por esta misma causa, en parte debido a las condiciones de la atmósfera —las que podrían evitarse fácilmente— de las galerías llenas de polvo, mezclado con anhídrido carbónico y grisú, derivan una gran cantidad de enfermedades crónicas dolorosas y peligrosas, especialmente el asma, que, en algunos distritos, sufre la mayor parte de los mineros cuando tienen 40 y aún 30 años, y los hace incapaces para el trabajo en poco tiempo" (*ibid.*:284-285, cursivas nuestras).

Que al capital, como dice Marx, le importa poco la salud y la vida de la clase trabajadora, ya que a aquél le interesa la máxima ganancia al menor costo posible, lo demuestra también Engels.

"Una enfermedad propia de este trabajo [en las minas] es el esputo negro, que proviene de la penetración del carbón fino en los pulmones, y se manifiesta, en general, con debilidad, dolores de cabeza, opresiones del pecho y expectoración negra y densa de mucosa. . . En todos los casos, este mal acarrea tras de sí la muerte. . . *La sed de ganancia de los propietarios de minas, que omiten la construcción de los pozos de ventilación, es culpable de la insistencia de esta enfermedad.* Los reumatismos. . . son una afección común de los obreros, y provienen de que los locales de trabajo, a menudo, están mojados. El resultado de todas estas enfermedades es que, en todos los distritos sin excepción, los mineros envejecen rápidamente y después de los 40 años —la edad varía en los diferentes distritos— son incapaces para el trabajo. Sucede rara vez que un minero, después de los 45 o 50 años, pueda seguir trabajando. A los 40 años, se reconoce generalmente, estos obreros empiezan a entrar en la vejez. Esto es válido para los que extraen el carbón; los cargadores, que deben levantar pesados bloques de carbón en los cofines, envejecen a los 28 o 30 años" (*ibid.*: 285-286; cursivas nuestras). Señala Engels: "Puede fácilmente imaginarse

cómo, por tan horrendo trabajo de esclavos, se favorecen las enfermedades propias de los mineros" (*ibid.*:287).

Existen, continúa Engels, "otras ramas del trabajo de las fábricas que tienen particulares consecuencias nocivas" para la salud. "En muchos locales, dedicados al hilado del algodón y del lino, se eleva una gran cantidad de polvo que proviene de los hilados, la cual produce, particularmente en los locales para cardar y peinar el lino, perturbaciones respiratorias. . . el obrero no tiene ninguna elección, debe aceptar la pieza donde está el trabajo, sea bueno o malo para su pecho. Las consecuencias que más comúnmente se derivan de respirar este polvo, son esputos de sangre, respiración dificultosa, dolores del pecho, tos, insomnio; en resumen, todos los síntomas del asma. . . El hilado de lino tiene otra consecuencia: la torsión característica de la espalda, y especialmente, la impostación hacia adelante del omóplato derecho, a causa de la naturaleza del trabajo. Este modo de hilar, y también el hilado del algodón en el *throstle*, producen a menudo enfermedades a la rodilla, que es empleada para la detención del huso, mientras se atan los hilos rotos. El frecuente curvarse en estas dos ramas de trabajo, y lo bajo de las máquinas, ocasionan, generalmente, un desarrollo defectuoso" (*ibid.*: 198-199).

Engels también señala que el trabajo en las fábricas detiene el desarrollo físico y el peso de los obreros en comparación con aquellos que no laboran en las fábricas: "Centenares de datos prueban que el desarrollo de los jóvenes es detenido por el trabajo; entre otros, Cowell da el peso de cuarenta y siete muchachos, todos de diecisiete años, y que van a la escuela dominical; veintiséis, ocupados en las fábricas, pesan, término medio, 104.5 libras inglesas, y veinte, que no trabajan en fábricas, pero que pertenecen a la clase obrera, pesan 117.7 libras" (*ibid.*:193-194).

También los daños a la salud son diferentes en los hijos de los obreros de las fábricas en comparación con los hijos de aquellos que desempeñan trabajos no fabriles: "La gran mortalidad de los hijos de los obreros y especialmente de los obreros de las fábricas, es prueba bastante clara de la insalubridad de condiciones en que pasan los primeros años. Tales causas actúan también sobre los muchachos que quedan con vida; naturalmente, no de modo tan intenso como sobre los que caen víctimas de ellas. Efecto de tales causas es, en el caso más favorable, una constitución enfermiza y un desarrollo incompleto, y por ello, una robustez menor que la normal. El hijo de nueve años de un

obrero, crecido en la indigencia, en las privaciones y en las condiciones más inestables, en la humedad, en el frío, vestido insuficientemente, y en una casa malsana, no tiene la capacidad de trabajo de un muchacho criado en condiciones de vida sana" (*ibid.*:184-185).

Para concluir, podemos señalar que lo expuesto por Marx y Engels permite demostrar que la explotación capitalista repercute de distinta manera en la salud de los diversos sectores de la clase obrera. Ello se debe a que, no obstante que existe un consumo capitalista de la fuerza de trabajo, la forma en que ésta se desgasta (según el tipo de plusvalía que se le extraiga) difiere de una a otra rama de la economía, de una a otra industria dentro de una misma rama, y dentro de una misma fábrica existen diversas ocupaciones que hacen que la incorporación al proceso productivo difiera de un grupo a otro dentro de la misma clase obrera.

Tal situación se debe a que existe un desarrollo diferente de las fuerzas productivas, al distinto grado de concentración y composición orgánica del capital y a las condiciones técnicas en que se lleva a cabo el proceso productivo.

Por lo tanto, puede concluirse que *existe una relación entre la forma en que grupos específicos de trabajadores producen y se reproducen y la forma como se enferman y de qué se enferman y mueren, así como el nivel de esperanza de vida que alcanzan.*

Lo anterior permite mostrar una vez más el carácter social de la enfermedad en tanto que depende de condiciones concretas de trabajo y de vida impuestas por el modo de producción capitalista en determinado momento histórico.

IV

El desarrollo industrial es desigual en las diversas regiones del país en que se instala el capitalismo. Las fábricas se establecen por lo general donde existe suficiente mano de obra y se cuenta con una infraestructura básica (carreteras, puertos, electricidad) y con mercados para el consumo de los productos. Por ello las ciudades representan el lugar preferido para implantar las fábricas, en tanto que el campo sirve como fuente de materias primas para la producción industrial.

Lo anterior conduce prontamente a que las ciudades se vean

abarrotadas por gente del campo que busca empleo en las fábricas. Al llegar a cierto punto los procesos de industrialización, urbanización y emigración desordenados provocan serios problemas de desempleo, vivienda, alimentación, transporte, contaminación ambiental, falta de servicios médicos, etcétera.

Tal situación repercute, sin lugar a dudas, en la salud de la población, sobre todo la que pertenece al proletariado que no cuenta con los medios suficientes y adecuados para hacer frente a las condiciones que originan las enfermedades y accidentes. Surge entonces en las ciudades una situación que ocasiona mayores enfermedades infecciosas, más estados de frustración, de stress, hipertensión, neurosis, accidentes y suicidios, que conforma la "patología urbana". Tal patología es producto del desempleo, el hacinamiento, la desnutrición, la contaminación ambiental, las condiciones de trabajo enajenantes. En el campo, en cambio, la población puede disfrutar del aire libre, dispone de diversos productos naturales para su alimentación y son menores las preocupaciones.

Lo anterior nos permite plantear otra tesis.

> Cuarta tesis: *Existe una situación diferente entre la ciudad y el campo en lo que respecta a las características de la morbimortalidad y en el nivel de esperanza de vida.*

Marx y Engels se interesaron en mostrar las diferencias entre la ciudad y el campo en relación con la enfermedad y la muerte para demostrar cómo el desarrollo industrial en las ciudades perjudica la salud de la clase trabajadora por la forma en que aquél se manifiesta, y que responde a las pautas de la acumulación capitalista.

Fuera de Londres —señala Marx— no se conocía en toda Inglaterra, a comienzos del siglo XIX, una sola ciudad que contase 100 000 habitantes. Sólo había cinco con más de 50 000. Hoy existen en Inglaterra 28 ciudades con más de 50 000 habitantes. 'Este cambio —apunta un informe de salud pública— no sólo ha traído como resultado un incremento enorme de la población urbana, sino que ha convertido a antiguas ciudades pequeñas, densamente pobladas, en centros de población edificados por todos los cuatro costados, sin salida alguna al aire libre' " (1973, I:560).

Tal situación no se queda ahí, ya que "cuanto más aprisa se acumula el capital en una ciudad industrial o comercial, más

rápida es la afluencia a ella de material humano explotable y más míseras las viviendas improvisadas de los obreros" (*ibid.*: 561), lo cual repercute como ya se ha demostrado en la salud de la población. "Recientemente —señala Marx— la policía se ha visto obligada a demoler un número considerable de casas en Newcastle y Gateshead, por constituir un peligro para la salud pública" (*ibid*). "En su informe del 5 de septiembre de 1865, el Dr. Bell, uno de los médicos de la Beneficencia de Bradford, declara que la espantosa mortalidad de los enfermos de fiebre de su distrito proviene de las malas condiciones de la vivienda" (*ibid.*:562). Y continúa Marx su análisis sobre las viviendas de los obreros en las ciudades: "¿Hace falta añadir que estas viviendas son casi siempre tugurios hediondos, húmedos, sucios, totalmente inadecuados para albergar a *seres humanos*? Éstos son los focos de los que irradian las enfermedades y la muerte" (*ibid.*: 563).

Como sabemos, las enfermedades del pulmón se encuentran ligadas al desarrollo industrial, por la contaminación que producen las fábricas, y al hacinamiento en viviendas y locales de trabajo estrechos, sin ventilación, que hace que las enfermedades infecciosas se difundan fácilmente.

Marx, al igual que Engels, proporciona información empírica al respecto. El primero de ellos demuestra, en base a los informes oficiales del doctor Greenhow, el nivel inferior de salubridad de los distritos fabriles, comparados con los "distritos agrícolas de salud normal". Sirva de prueba y a modo de ejemplo el siguiente cuadro, tomado de un informe de 1861 (Marx 1973, I:233).

Porcentaje de obreros varones adultos empleados en las manufacturas	Coeficiente de mortalidad en enfermedades del pulmón por cada 100 000 hombres	Nombre del distrito	Coeficiente de mortalidad en enfermedades del pulmón por cada 100 000 hombres	Porcentaje de mujeres empleadas en la manufactura	Clase de trabajo de las mujeres
14.9	593	Wigan	644	18.0	Algodón
42.6	708	Blackburn	734	34.9	Algodón
37.3	547	Halifax	564	20.4	Estambre
41.9	611	Bradford	603	30.0	Estambre
31.0	691	Macclesfield	804	26.0	Seda
14.9	588	Leck	705	17.2	Seda
36.6	721	Stoke-upon-Trent	665	19.3	Loza
30.4	726	Woolstanton	727	13.9	Loza
	305	Ocho distritos agrícolas sanos	340		

En relación con la tuberculosis, de la que Marx señalaba que era la condición de vida del capitalismo, presenta los siguientes datos: "De la estadística de mortalidad con referencia a las industrias explotadas en locales cerrados e investigadas por la oficina de sanidad en los años de 1860 y 1861 se deduce lo siguiente: para el mismo número de hombres cuya edad oscila entre los 15 y 55 años y a los que corresponden en los distritos agrícolas de Inglaterra 100 casos de muerte por tuberculosis y otras enfermedades de los pulmones, se registran las siguientes cifras de mortalidad: en Coventry, 163 casos de muerte por tuberculosis; en Blackburn y Skipton, 167; en Congleton y Bradford, 168; en Leicester, 171; en Leek, 182; en Macclesfield, 184; en Bolton, 190; en Nottingham, 192; en Rochdale, 193; en Derby, 198; en Salford y Ashton-under-Lyne, 203; en Leeds, 218; en Preston, 220 y en Manchester, 263. Pero aún es más pavorosa la imagen que arroja el cuadro siguiente. En él se presentan los casos de muerte por enfermedades del pulmón distinguiendo entre ambos sexos desde los 15 a los 25 años y por cada 100 000 personas. Los distritos escogidos para hacer la investigación han sido aquellos en que sólo son mujeres las que trabajan en la industria explotada en locales cerrados, mientras que los hombres se dedican a todas las posibles ramas de trabajo.

Distrito	Industria principal	Casos de muerte por enfermedades del pulmón entre los 15 y los 25 años calculando por cada 100 000 personas	
		Hombres	Mujeres
Berkhamstead	Tejidos de paja, a cargo de mujeres	219	578
Leighton Buzzard	Tejidos de paja, a cargo de mujeres	309	554
Newport Pagnell	Fabricación de puntillas, por mujeres	301	617
Towcester	Fabricación de guantes, por mujeres en su mayoría	239	577
Yeovil	Fabricación de guantes, por mujeres en su mayoría	280	409
Leek	Industria sedera, en que predominan mujeres	437	856
Congleton	Industria sedera, en que predominan mujeres	566	790
Macclesfield	Industria sedera, en que predominan mujeres	593	890
Comarcas sanas	Agricultura	331	333

"En los distritos de la industria sedera donde es mayor el número de hombres que participan en el trabajo fabril, es también considerable su coeficiente de mortalidad. La cuota de mortalidad por tuberculosis, etcétera, en ambos sexos revela aquí, como dice la memoria, 'Las espantosas *(atrocious)* condiciones sanitarias en que se explota gran parte de nuestra industria sedera' " (1973, III:104-105).

Engels también da información empírica para mostrar las diferencias en la morbimortalidad entre la ciudad y el campo, a fin de demostrar que el desarrollo industrial provoca mayor tasa de mortalidad general e infantil y más epidemias y enfermedades del sistema nervioso y trastornos digestivos.

"Según el informe del encargado del registro general, G. Graham, la mortalidad en Inglaterra y en Gales es, anualmente, en poco inferior al 2.5%; esto significa que de cuarenta y cinco personas, muere al año una. Por lo menos, éste era el término medio en el año 1839-40; en los últimos años descendió algo la mortalidad y fue solamente de uno sobre cuarenta y seis. Pero en las grandes ciudades la condición es completamente diferente. Tengo delante de mí (en el *Manchester Guardian* del 31 de julio de 1844) las estadísticas oficiales de la mortalidad, según las cuales se estima la mortalidad, en cada una de las grandes ciudades, de la siguiente manera: en Manchester, incluido Salford y Chorlton, un deceso sobre 32.72 habitantes; excluidos Salford y Chorlton, un deceso sobre 30.75; en Liverpool, incluido West-Derby, uno sobre 31.90, y excluido West-Derby, uno sobre 29.90; mientras la media de todos los nombrados distritos de Cheshire, Lancashire y Yorkshire —que comprenden numerosos distritos completamente o en parte agrícolas, con muchas pequeñas ciudades— con una población de 1 172 506 almas, da un deceso por cada 39.80 habitantes" (Engels 1977:139).

"Cuán mal están los obreros en las ciudades —continúa Engels— lo demuestra la mortalidad en Prescott, en el Lancashire —distrito habitado por obreros de las minas de carbón, cuyo trabajo no es precisamente salubre— que se encuentra, en lo relativo a las condiciones sanitarias, por debajo de un distrito agrícola. Para los obreros que habitan en el campo la mortalidad es de uno sobre 47.54 personas, con una ventaja, sobre la media de toda Inglaterra, del 21/2%. Todos estos datos se basan en las tablas de la mortalidad del año 1843. Más alto es el promedio de la mortalidad en las ciudades escocesas" (*ibid.*:139-140).

En cuanto a la mortalidad de niños menores de cinco años,

Engels señala que la media de la mortalidad, perteneciente a todas las clases, en los distritos de campo, no es ni siquiera del 32%, mientras que, por ejemplo, en Manchester el 57% de los niños de la clase obrera muere antes de los cinco años. "El artículo citado del *Artisan* nos aporta cifras exactas, que confrontan los casos de muerte, por las diferentes enfermedades, de los niños de las ciudades con los del campo, y prueba que las epidemias son, en general, tres veces más mortales en Manchester y en Liverpool que en los distritos agrícolas; que las enfermedades del sistema nervioso se han centuplicado, y los trastornos digestivos se han duplicado en las ciudades, y en los casos de muerte a consecuencia de enfermedades crónicas, están en las ciudades en proporción de 2 1/2 a 1 con los del campo. En las ciudades, los casos de muerte de los niños, después de una viruela, rubeola, tos convulsa o fiebre escarlatina, son cuatro veces mayores; después de una hidrocefalia, tres veces mayores, y diez veces más, enseguida de las convulsiones... Y para citar todavía a una indiscutible autoridad, transcribo una tabla del Dr. Wade, de acuerdo con el informe del comité parlamentario para las fábricas, en el año 1832, en su *History of the Middle and Working Classes* (Londres, 1835, 3rd. ed.)" (1977:141-142).

Cantidad de muertes producidas sobre 10 000 hombres

	Menos de 5 años	5-19 años	20-39 años	40-59 años	60-69 años	70-79 años	80-89 años	90-99 años	100 años
En el condado de Rutland, distrito agrícola salubre	2 865	891	1 275	1 299	1 189	1 428	939	112	3
En el condado de Essex, distrito agrícola palúdico	3 159	1 110	1 526	1 413	963	1 019	630	177	3
En la ciudad de Carlyle, 1779-87, antes de la introducción de las máquinas	4 408	921	1 006	1 201	940	826	533	153	22
En la ciudad de Carlyle, después de la introducción de las máquinas	4 738	930	1 261	1 134	677	727	432	80	1
En la ciudad de Preston, industrial	4 947	1 136	1 379	1 114	553	532	298	38	3
En la ciudad de Leeds, industrial	5 206	927	1 228	1 198	593	512	295	29	2

Cuando el capitalismo se introduce en el campo deja sentir sus repercusiones en la salud de la población al incrementarse las enfermedades infecciosas. Marx analiza una situación concreta: "En los distritos agrícolas, donde el número de mujeres que trabajan alcanza la cifra mínima, la cifra de mortalidad es la más baja (en comparación con los distritos industriales). Sin embargo, la comisión investigadora de 1861 llegó a la conclusión inesperada de que en algunos distritos puramente agrícolas situados junto al mar del Norte el coeficiente de mortalidad de niños menores de un año, alcanzó casi la cifra de los distritos fabriles de peor fama. El Dr. Julian Hunter fue el encargado de investigar sobre el terreno este fenómeno. Su informe figura anexo al *VI Report on Public Health*. Hasta entonces se había supuesto que el paludismo y otras enfermedades características de comarcas bajas y pantanosas diezmaban la población infantil. Esta investigación condujo precisamente al resultado contrario, a saber: 'que la *misma causa* que eliminaba el paludismo, o sea, la transformación de los suelos pantanosos en invierno y pastizales en verano en fecunda tierra triguera, era la que provocaba la extraordinaria mortalidad infantil'. Los setenta médicos en ejercicio interrogados por el Dr. Hunter en aquellos distritos, se manifestaron con 'maravillosa unanimidad' acerca de este punto. ¿Qué ocurría? La revolución operada en el cultivo de la tierra llevaba aparejado el *sistema industrial*" (Marx 1973, I:327).

Cuán acelerada y profundamente ha mordido en las raíces vitales de las energías del pueblo la producción capitalista, lo demuestran los obreros campesinos que, a pesar del aire libre, comienzan ya a caducar, señala Marx, quien para demostrar lo anterior cita un estudio (*Public Health. Sixth Report of the Medical Officer of the Privy Council*, 1863). "Este dictamen trata especialmente de los obreros agrícolas. 'Se ha presentado al Condado de Sutherland como una comarca muy mejorada, pero una reciente investigación ha descubierto que, en distritos tan famosos en otro tiempo por la belleza de sus hombres y la bravura de sus soldados, los habitantes han degenerado en una raza flaca y raquítica. En los sitios más sanos, en las vertientes de las colinas que miran al mar, sus niños tienen unas caras tan delgadas y tan pálidas como sólo se encuentran en la atmósfera pestilente de la peor callejuela de Londres' " (Marx 1973, I:211).

Marx demuestra, por lo tanto, cómo la presencia del capi-

talismo en el campo conduce al empobrecimiento físico de la fuerza de trabajo, lo cual origina mayores enfermedades, ya que "destruye la salud física de los obreros [puesto que] al igual que en la industria urbana, en la moderna agricultura la intensificación de la fuerza productiva y la más rápida movilización del trabajo se consiguen a costa de devastar y agotar la fuerza de trabajo del obrero" (Marx 1973, I:423).

En relación con el desarrollo físico, manifestación concreta de las condiciones materiales de vida, y que constituye un indicador de la salud-enfermedad de la población, Engels apunta lo siguiente: "en Manchester, pueden encontrarse reclutas de apenas cinco pies y ocho pulgadas; la talla oscilaba entre las seis y siete pulgadas, mientras que en los distritos agrícolas, la mayor parte alcanza las ocho pulgadas" (1977:194).

Cuando las fábricas se instalan en el campo, alejadas de los problemas de las ciudades (contaminación ambiental, hacinamiento, entre otros) los hijos de los trabajadores tienen un mejor desarrollo que los de la ciudad. Esto fue observado por Engels: "es necesario anotar que en Escocia, la mayor parte de las fábricas están en el campo, excepto las de Glasgow, y esto contribuye muchísimo al fortalecimiento de las muchachas; los hijos de los obreros, en los alrededores de Manchester, son florecientes y frescos mientras que en la ciudad tienen un aspecto pálido y escrofuloso; pero hacia los nueve años, el color se desvanece, porque son enviados a las fábricas y bien pronto no se los puede distinguir de los chicos de la ciudad" (1977:198).

Las observaciones de Marx y Engels en relación con la diferencia en la morbimortalidad y la esperanza de vida entre la ciudad y el campo demuestran que la enfermedad y la muerte son fenómenos que adquieren sus propias particularidades según las zonas en que el desarrollo capitalista divide a los países: zonas urbanas y rurales.

La encuesta obrera de Marx

En una carta a Sorge del 5 de noviembre de 1880, Marx escribió que había redactado para la *Revue Socialiste* de Benoit Malon un "Questionneur" *(sic)* del que se habían distribuido muchas copias por toda Francia. "Poco después, Guesde vino a Londres a preparar en colaboración con nosotros (yo, Engels y Lafargue)

un programa electoral para los obreros, con motivo de las próximas elecciones".*

El cuestionario se publicó por primera vez en la *Revue Socialiste* el 20 de abril de 1880. Además se distribuyeron 25 mil ejemplares "a todas las sociedades obreras, a los grupos y círculos socialistas y democráticos, a los periódicos franceses y a todos los que lo pidieron". Estos ejemplares no llevaban fecha.

El texto del cuestionario va precedido de un breve prefacio que recuerda los estudios y encuestas realizados por el gobierno inglés sobre las condiciones de la clase obrera y recomienda al gobierno francés que le imite. Exhorta a los obreros de la ciudad y del campo a contestar las preguntas del cuestionario, porque sólo ellos pueden describir "con pleno conocimiento de causa los males que soportan", "sólo ellos y no un salvador providencial puede administrar enérgicamente los remedios de los males sociales que padecen". El llamamiento va dirigido también a los "socialistas de todas las escuelas que desean la reforma social y deben desear, por consiguiente, tener un conocimiento exacto y positivo de las condiciones en que vive y trabaja la clase obrera, la clase a que pertenece el futuro".

El prefacio declara, finalmente, que "las respuestas se clasificarán y suministrarán datos para una serie de artículos especiales, que se publicarán en la *Revue Socialiste*, para reunirse posteriormente en un volumen".*

El cuestionario se divide en cuatro partes y contiene, en total, 101 preguntas. La primera parte se refiere al empleo y las condiciones de trabajo; la segunda a los horarios de trabajo y de tiempo libre; la tercera a las condiciones del contrato de trabajo, a los salarios y al costo de la vida; la cuarta, a la lucha de la clase obrera por la mejora de sus condiciones.

El texto íntegro del cuestionario aparece en el apéndice.

*Texto tomado de: Karl Marx, *Sociología y filosofía social*, selección e introducción de T. B. Bottomore y M. Rubel, Historia/Ciencia/Sociedad 15, Ediciones Península.

*En realidad, no se publicó ningún resultado de la encuesta. El número de la *Revue Socialiste* del 5 de julio de 1880 decía que se habían recibido muy pocas respuestas y pedía a los lectores que enviasen las suyas lo más pronto posible. En los números siguientes no se hizo referencia alguna a la encuesta y la *Revue* dejó de publicarse en 1881.